

PENDIDIKAN SEKSUAL KOMPREHENSIF SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI, SERTA KEKERASAN PADA ANAK DAN PEREMPUAN

Sofa Qurrata A'yun
Dina Camelia

PENDIDIKAN SEKSUAL KOMPREHENSIF SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI, SERTA KEKERASAN PADA ANAK DAN PEREMPUAN

Penulis:

Bdn. Sofa Qurrata A'yun, SST., MTr.Keb.,
Dina Camelia, S.Kep., Ns., MTr.Kep.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Pendidikan Seksual Komprehensif Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini, Serta Kekerasan Pada Anak Dan Perempuan

Penulis: Bdn. Sofa Qurrata A'yun, SST., MTr.Keb.,
Dina Camelia, S.Kep., Ns., MTr.Kep.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Tata Letak: Helmi Syaukani

ISBN: 978-634-7139-11-5

Cetakan Pertama: Februari, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram: @bimbel.optimal



PENERBIT:

Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

JUDUL DAN
PENANGGUNG JAWAB

Pendidikan seksual komprehensif sebagai upaya pencegahan pernikahan usia dini, serta kekerasan pada anak dan perempuan / penulis, Bdn. Sofa Qurrata A'yun, SST., MTr.Keb., Dina Camelia, S.Kep., Ns., MTr.Kep.

EDISI
PUBLIKASI
DESKRIPSI FISIK
IDENTIFIKASI
SUBJEK
KLASIFIKASI
PERPUSNAS ID

Cetakan pertama, Februari 2025
Jakarta Barat : PT Nuansa Fajar Cemerlang, 2025
vi, 94 halaman ; 30 cm
ISBN 978-634-7139-11-5
Pendidikan seks untuk remaja -- Pendidikan seks untuk wanita
613.951 [23]

<https://isbn.perpusnas.go.id/bo-penerbit/penerbit/isbn/data/view-kdt/1188046>

PRAKATA

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karuniaNya pada akhirnya kami dapat menyelesaikan tulisan berupa buku yang berjudul **Pendidikan Seksual Komprehensif untuk Pencegahan Pernikahan Usia Dini, Kekerasan Pada Anak dan Perempuan**, ini dapat diselesaikan. Tanpa Izin Allah Buku ini tidak akan pernah bisa terwujud.

Keterbatasan, Kekurangan, dan kelemahan telah banyak mewarnai penulis dalam menyelesaikan buku ini, mengingat buku ini merupakan kumpulan, bahkan pendapat beberapa pihak yang berkompeten dibidangnya masing-masing. Lebih jelasnya buku ini bahannya berasal dari saran dari pihak manapun. Namun dengan keyakinan yang disertai bantuan dan partisipasi serta kerjasama yang baik dari semua pihak, sehingga rintangan itu dapat teratasi.

Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi banyak orang, dan setiap saran serta umpan balik untuk perbaikan sangat kami harapkan. Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga selesainya penulisan buku yang belum sempurna ini, kami berdoa dan memohon kepada Allah SWT, terimakasih pula teruntuk pemberi dukungan penuh suamiku tersayang beserta anak - anakku, keluarga besar Muna'im, terlebih kepada ayahanda beserta ibunda yang telah tiada, tanpa babah dan ummi saya belum tentu sampai di titik ini.

semoga semua pihak yang materinya kami kutib agar selalu mendapatkan kesehatan, rejeki yang melimpah serta pahala dan diampuni seluruh dosa-dosanya, Aamiin.

Januari, 2025

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

BAB 1 PENDAHULUAN 1

BAB 2 KONSEP REMAJA, KEKERASAN PADA ANAK & HUKUM YANG MENGATUR..... 7

A. Konsep Remaja	7
B. Konsep Kekerasan Pada Anak & Perempuan.....	15
C. Aspek Legal Hukum Tentang Perlindungan Anak & Perempuan	34

BAB 3 PERILAKU SEKSUAL PRANIKAH & PERNIKAHAN USIA DINI 39

A. Perilaku Seksual Pranikah	39
B. Pernikahan Usia Dini.....	44
C. Perilaku Seksual Pranikah	50
D. Remaja	54

BAB 4 PENDIDIKAN SEKSUAL KOMPREHENSIF SEBAGAI UPAYA PERNIKAHAN USIA DINI DAN KEKERASAN PADA ANAK & PEREMPUAN..... 59

A. Pendidikan Seksual Komprehensif	59
--	----

BAB 5 PENUTUP 69

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA.....	73
GLOSARIUM	81
PROFIL PENULIS	85

BAB 1

PENDAHULUAN

Pernikahan dini merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan (Luthfiyah, 2022). Pola pikir zaman primitif dengan zaman yang sudah berkembang jelas berbeda, hal ini dibuktikan dengan sebuah paradoks perkawinan antara pilihan orang tua dengan kemauan sendiri, pernikahan dini dipaksakan atau pernikahan dini karena kecelakaan. Namun prinsip orang tua pada zaman genepo atau zaman primitif sangat menghendaki jika anak perempuan sudah baligh maka tidak ada kata lain kecuali untuk secepatnya menikah. Kasus pernikahan usia dini banyak terjadi di berbagai penjuru dunia dengan berbagai latar belakang. Telah menjadi perhatian komunitas internasional mengingat risiko yang timbul akibat pernikahan yang dipaksakan, hubungan seksual pada usia dini, kehamilan pada usia muda, dan infeksi penyakit menular seksual. Kemiskinan bukanlah satu satunya faktor penting yang berperan dalam pernikahan usia dini. Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu risiko komplikasi yang terjadi di saat kehamilan dan saat persalinan pada usia muda, sehingga berperan meningkatkan angka kematian ibu dan bayi. Selain itu, pernikahan di usia dini juga dapat menyebabkan gangguan perkembangan kepribadian dan menempatkan anak yang dilahirkan berisiko terhadap kejadian kekerasan dan keterlantaran. Masalah pernikahan usia dini ini merupakan kegagalan dalam perlindungan hak anak. Dengan demikian diharapkan semua pihak termasuk dokter anak, akan

meningkatkan kepedulian dalam menghentikan praktek pernikahan usia dini. (Sari Pediatri, 2022). Kondisi demikian, dilatar belakangi oleh keberadaan zaman yang masih tertinggal, maka konsep pemikirannyapun tidak begitu mengarah pada jenjang kehidupan masa depan yang lebih baik. Tradisi pernikahan zaman nenek moyang lebih teracu dengan prospek budaya nikah dini, yakni berkisar umur 15 tahun para wanita dan pria berkisar umur 20 tahun atau kurang (Dlari, 2022).

Perkawinan yang sehat memenuhi kriteria umur calon pasangan suami istri adalah memenuhi umur. Kurun waktu reproduksi sehat yaitu umur 20-35 tahun, karena berkaitan dengan kesehatan reproduksi wanita. Secara biologis organ reproduksi lebih matang apabila terjadi proses reproduksi secara psikososial. Kisaran umur tersebut wanita mempunyai kematangan mental yang cukup memadai. Secara sosial demografi wanita telah menyelesaikan proses pendidikan. Perkawinan yang sehat memenuhi kaidah kesiapan pasangan suami istri dalam aspek biopsikososial, ekonomi dan spiritual (Wahyuningsih dkk, 2022). Akibat pernikahan dini, para remaja saat hamil dan melahirkan akan sangat mudah menderita anemia. Dan ketidaksiapan fisik juga terjadi pada remaja yang melakukan pernikahan dini akan tetapi juga terjadi pada anak yang dilahirkan. Dampak buruk tersebut berupa bayi lahir dengan berat rendah, hal ini akan menjadikan bayi tersebut tumbuh menjadi remaja yang tidak sehat tentunya ini juga akan berpengaruh pada kecerdasan buatan si anak dari segi mental (Manuaba, 2022). Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, menyarankan kaum muda untuk menghindari pernikahan di usia dini guna menghindari kemungkinan terjadinya resiko kanker leher rahim (kanker serviks) pada pasangan istri, serta berdsarkan pasal 6 ayat 2

UU No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melangsungkan suatu perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 20 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua (Burhani, 2022).

Upaya pencegahan pernikahan anak dibawah umur dirasa akan semakin maksimal bila anggota masyarakat turut serta berperan aktif dalam pencegahan pernikahan anak dibawah umur yang ada disekitar mereka. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat merupakan jurus terampuh sementara ini untuk mencegah terjadinya pernikahan anak dibawah umur sehingga kedepannya diharapkan tidak ada lagi anak yang menjadi korban akibat pernikahan tersebut dan anak-anak Indonesia bisa lebih optimis dalam menatap masa depannya kelak, (Alfiyah, 2022).

Perempuan dan anak-anak menghadapi risiko kejahatan yang tinggi dan karena itu membutuhkan pengamanan. Anak-anak memainkan peran penting baik dalam kelangsungan hidup umat manusia maupun kesejahteraan bangsa dan pemerintahannya. Konstitusi Indonesia secara eksplisit mengakui kepentingan strategis anak dan menjamin hak mereka atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Akibatnya, memprioritaskan kepentingan terbaik anak-anak sangat penting tidak hanya untuk kesejahteraan mereka sendiri tetapi juga untuk kelangsungan hidup dan kemakmuran masyarakat secara keseluruhan (Hurairah, 2022).

Kekerasan terhadap perempuan dan anak memiliki konsekuensi yang mendalam dan berjangkauan jauh, yang menyebabkan kerugian yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Kekerasan ini berdampak buruk pada kesehatan, kesejahteraan sosial, dan stabilitas ekonomi mereka. Dalam hal kesehatan, hal itu menyebabkan cedera fisik dan

mental, kecacatan, dan masalah kesehatan terkait lainnya, yang selanjutnya melanggengkan siklus kekerasan. Selain itu, ada dampak negatif terhadap prestasi pendidikan, yang mengakibatkan rendahnya capaian pendidikan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan dan anak meliputi perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, dan seksual, serta penelantaran. Bentuk kekerasan ini tetap menjadi topik diskusi yang menonjol di antara berbagai kelompok. Perempuan dan anak sering menjadi korban berbagai bentuk kekerasan, termasuk diskriminasi dan pelecehan. (Hurairah, 2022). Biasanya, bentuk-bentuk kekerasan yang umum terjadi melibatkan pelanggaran seksual, seperti pemerkosaan, dan tindakan agresi fisik, seperti penyerangan. Namun, penting untuk menyadari bahwa kekerasan melampaui manifestasi fisik dan seksual saja; itu juga mencakup kerugian psikologis atau emosional. Isu kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi semakin meresahkan ketika pemerintah gagal memberikan dukungan dan bantuan yang memadai kepada para korban. Hurairah, 2022).

Saat ini, berbagai peristiwa kekerasan terus terjadi, di antaranya adalah kejahatan yang secara khusus menyasar perempuan dan anak. Tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan perbuatan yang merendahkan, merendahkan, dan merendahkan martabatnya, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian fisik dan/atau psikis. Tindakan semacam itu berpotensi mengganggu kesejahteraan mereka di berbagai tingkatan (Huraerah, 2022).

Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), mayoritas korbannya adalah perempuan. Perempuan, sebagai kelompok rentan, seringkali mengalami perlakuan tidak adil, sehingga menimbulkan ketidakadilan berbasis gender. Ketidak

adil gender terwujud dalam berbagai bentuk, seperti peminggiran atau pemiskinan ekonomi, subordinasi atau dianggap tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotip atau pelabelan negatif, kekerasan, dan beban timbunan beban kerja yang lebih lama dan lebih berat. Kekerasan yang bersumber dari bias gender juga disebut sebagai kekerasan terkait gender (Saraswati, 2022).

BAB 2

KONSEP REMAJA, KEKERASAN PADA ANAK & HUKUM YANG MENGATUR

A. Konsep Remaja

Masa remaja adalah masa peralihan dimana perubahan secara fisik dan psikologi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, bukan hanya dalam artian psikologis tetap juga fisik. Bahkan perubahan-perubahan fisik yang terjadi itulah yang merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja, sedangkan perubahan-perubahan psikologis muncul antara lain sebagai akibat dari perubahan-perubahan fisik itu (Sarwono, 2022).

Masa remaja merupakan tahap perkembangan psikologis yang potensial dan rentan, dikenal dengan fase mencari jati diri, karena difase ini mereka sudah tidak bisa dikatakan anak-anak namun juga belum bisa dikatakan sebagai golongan orang yang sudah dewasa, dan juga pada fase ini remaja belum mampu menguasai dan memfungsikan secara maksimal fungsi fisik maupun psikisnya (Fauzia & Rahmaji, 2022).

Remaja memiliki beberapa tugas perkembangan salah satunya yaitu mampu menerima keadaan fisiknya, sehingga perkembangan bagi remaja untuk bisa menerima keadaan fisik atau citra tubuh (*body image*) merupakan hal yang penting untuk memenuhi tugas perkembangannya, jika remaja tidak mampu menerima *body image* yang dimiliki, dapat mempengaruhi perilaku atau tindakan sehari-hari seperti kepercayaan diri, perilaku diet, pola

makan, dan lain-lain (Ramanda et al., 2022). Maka, pada masa remaja penting dalam meninjau *body image*.

Periode *adolenses* yaitu periode perubahan dari anak-anak menjadi dewasa, dalam masa ini berbagai perubahan terjadi baik perubahan hormone, fisik, psikologi ataupun social. Perubahan fisik yang menonjol yaitu perkembangan tanda-tanda seks, dan perubahan perilaku serta hubungan sosial dengan lingkungannya (Batubara, 2010). Menurut *The Health Resourch dan Service Administrations Guidelines* Amerika Serikat rentang usia remaja yaitu 11-21 tahun serta terbagi menjadi tiga tahap, yakni remaja awal (11-14 tahun), remaja menengah (15-17 tahun), remaja akhir (18-21 tahun).

1. Batasan usia remaja

Menurut Marmi (2021), batasan usia remaja yaitu:

- a. Masa remaja awal (*early adolescence*) yaitu 11- 13 tahun, dengan ciri khas: ingin bebas, lebih dekat dengan teman sebaya, mulai berpikir abstrak dan lebih banyak memperhatikan keadaan tubuhnya.
- b. Masa remaja tengah (*middle adolescence*) yaitu 14-16 tahun, dengan ciri khas: mencari identitas diri, timbulnya keinginan untuk berkencan, mempunyai rasa cinta yang mendalam dan berkhayal tentang aktivitas seks.
- c. Masa remaja akhir (*late adolescence*) yaitu 17- 20 tahun, dengan ciri khas: mampu berfikir abstrak, lebih selektif dalam mencari teman sebaya, mempunyai ciri tubuh (*body image*) terhadap dirinya sendiri, dapat mewujudkan rasa cinta, pengungkapan kebebasan diri.

Berdasarkan tahapan perkembangan individu dari mulai bayi hingga masa tua akhir menurut Erickson,

masa remaja dibagi menjadi tiga tahapan yakni masa remaja awal, masa remaja pertengahan, masa remaja akhir. Adapun kriteria usia masa remaja awal perempuan yaitu 13-15 tahun dan pada laki-laki yaitu 15-17 tahun. Kriteria usia remaja pertengahan pada perempuan yaitu 15-18 tahun dan pada laki-laki 17-19 tahun, sedangkan kriteria usia remaja akhir pada perempuan yaitu 18-21 tahun dan pada laki-laki 19-21 tahun (Thalib, 2020).

Rata-rata usia anak SMA di Indonesia adalah sekitar 15-18 tahun. Berdasarkan ketentuan dan syarat PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) SD, SMP dan SMA tahun 2019 bahwa usia maksimal masuk SMA adalah 21 tahun. Pada masa remaja pertengahan remaja lebih membutuhkan banyak teman yang menyukainya dan memiliki sifat yang sama dengan dirinya. Remaja pada tahap ini cenderung memiliki sifat mencintai diri sendiri dan berada pada masa kebingungan untuk memutuskan suatu tindakan. Pada remaja laki-laki lebih mempercepat hubungan dengan lawan jenis.

a. Karakteristik Perkembangan Remaja

Karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja bisa dilihat dari 3 dimensi yakni dimensi logis, dimensi kognitif serta dimensi sosial.

1) Dimensi biologis

Menstruasi pertama pada remaja putri serta mimpi basah pada remaja putra merupakan tanda seorang anak memasuki masa pubertas, secara biologis remaja mengalami perubahan yang sangat besar. Pubertas menjadikan seorang anak mempunyai kemampuan untuk dapat bereproduksi.

Pada saat memasuki masa pubertas, anak perempuan bakal mengalami menstruasi sebagai tanda bahwa sistem reproduksinya sudah aktif. Sejalan dengan itu juga remaja akan mengalami perubahan fisik yaitu payudara mulai berkembang, panggul mulai membesar, timbul jerawat serta tumbuh rambut pada daerah kemaluan. Sedangkan pada anak laki-laki akan kelihatan perubahan pada suara, tumbuhnya kumis, jakun, alat kelamin menjadi lebih besar, otot-otot membesar. Munculnya jerawat serta perubahan fisik yang lain. Bentuk fisik akan berubah secara cepat sejak awal pubertas dan akan membawa mereka ke dalam dunia remaja.

2) Dimensi Kognitif

Menurut Jean Piaget (2022) yang merupakan seorang ahli perkembangan kognitif mengemukakan bahwa perkembangan kognitif remaja yaitu masa terakhir serta tertinggi pada tahap pertumbuhan operasi formal (*period of formal operation*). Dalam periode ini, seyogyanya para *adolesens* telah memiliki pola pikir sendiri sehingga dapat berusaha menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks dan abstrak. Kemampuan remaja dalam berpikir berkembang sedemikian rupa dimana mereka dengan mudah bisa membayangkan banyak pilihan pemecahan masalah beserta kemungkinan dampak atau hasilnya. Para remaja tidak lagi menerima informasi apa adanya, tetapi mereka akan memproses informasi itu serta mengadaptasikannya dengan pemikiran mereka sendiri. Mereka juga mampu

mengintegrasikan pengalaman lalu dan sekarang untuk ditransformasikan menjadi konklusi, prediksi, dan rencana untuk masa depan.

3) Dimensi Sosial

Masa remaja yaitu proses dimana seseorang mulai bertanya-tanya mengenai berbagai fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya tentang bermacam kejadian yang berlangsung di lingkungan sekitarnya sebagai dasar bagi pembentukan kualitas diri mereka sendiri. Remaja akan mulai melahirkan penilaian tersendiri di dalam menghadapi masalah-masalah populer dimana berkenaan dengan lingkungan mereka, contohnya politik, kemanusiaan, perang, keadaan sosial dan sebagainya. Dalam kondisi ini remaja tidak lagi menerima hasil pemikiran yang kaku, sederhana, serta absolut yang diberikan kepada mereka selama ini tanpa bantahan. Perubahan lain yaitu remaja mulai mempertanyakan keabsahan pemikiran yang ada serta mempertimbangkan lebih banyak alternatif lainnya. Secara kritis, *adolenses* mulai lebih banyak melaksanakan pengamatan keluar serta membandingkan terhadap hal-hal yang selama ini diajarkan serta ditanamkan kepadanya.

b. Perubahan-Perubahan yang Terjadi Pada Remaja

Perubahan yang terjadi antara lain:

1) Perubahan Fisik

Perubahan fisik yaitu perubahan yang terjadi pada seseorang tentang perubahan jasmani, seperti tinggi badan, berat badan, dan sebagainya.

Dibawah ini merupakan beberapa perubahan fisik yang terjadi pada remaja:

a) Laki-laki

Perubahan yang dialami yaitu: pertumbuhan tulang-tulang, testis (buah pelir) membesar, tumbuh bulu kemaluan, awal perubahan suara, ejakulasi (keluar air mani), pertumbuhan tinggi badan mencapai tingkat maksimum setiap tahun, tumbuh rambut-rambut halus di wajah (kumis, jenggot), tumbuh bulu ketiak, rambut-rambut di wajah bertambah tebal serta gelap, tumbuh bulu pada dada, dan lain sebagainya.

b) Perempuan

Perubahan yang dialami yaitu: pertumbuhan tulang-tulang (badan menjadi tinggi, anggota-anggota badan menjadi Panjang), pertumbuhan payudara, tumbuh bulu yang halus berwarna gelap pada kemaluan, mencapai pertumbuhan ketinggian badan yang maksimum setiap tahun, menstruasi, tumbuh bulu-bulu ketiak dan lain sebagainya.

2) Perubahan Psikis

Perubahan psikis yaitu perubahan tentang rohani seseorang yaitu tingkah laku, sikap, mental, dan lain sebagainya. Dibawah ini merupakan beberapa perubahan psikis yang terjadi pada masa remaja.

a) Keadaan emosi yang tidak stabil menyebabkan remaja gampang merasa gembira dan mudah sedih. Situasi ini menjadikan remaja mempunyai emosi yang meledak-ledak.

- b) Perasaan berubah sangat peka atau sensitif. Keadaan tertentu bisa membuat remaja gampang tersentuh dan tersinggung.
- c) Sikap mental agresif, ditunjukkan dalam bentuk suka menentang pada aturan ataupun perintah. Situasi ini hadir dalam diri remaja, dimana muali merasakan bahwa ia sudah tidak mau lagi disebut sebagai anak kecil serta menganggap dirinya telah dewasa serta memiliki hak menentukan pilihan dan kemauannya sendiri.
- d) Mulai mencari identitas diri. Hal ini dimunculkan pada berbagai perilaku, yaitu:
 - (1) Senang berkelompok melaksanakan kegiatan Bersama kelompoknya
 - (2) Senang melaksanakan hal-hal yang menantang, dimana cenderung memuaskan perasaan ingin tahu yang begitu besar pada sesuatu hal, dengan demikian anak remaja selalu melakukan sesuatu yang di luar perhitungan akan kemampuannya. Senang menarik perhatian orang lain serta melakukan sesuatu yang menyalahi aturan pada umumnya.
 - (3) Permasalahan yang muncul karena perubahan fisik dan psikis remaja:
 - Ketidak matangan intelektual serta emosional. Dimana berakibat pada tindakan yang tidak rasional, cenderung emosional serta tanpa berpikir panjang.
 - Penerimaan (akseptansi) menyeluruh pada setiap perubahan bentuk dan fungsi tubuhnya sebagai usaha

penyesuaian diri terhadap pertumbuhan serta perkembangannya. Remaja merasa tidak puas akan penampilannya. Mereka terhambat dalam hal akseptansi karena menyadari pentingnya penampilan dalam penerimaan social. Ditambah lagi pada saat pubertas ini, minat terhadap jenis kelamin lain mulai berkembang juga.

- Perkembangan seksual yang meningkat. Pemuasan dorongan seks masih dipersulit dengan banyaknya tabu social, sekaligus kekurangan pengetahuan yang valid mengenai seksualitas yang pada awalnya berupa keinginan untuk jatuh cinta atau bercinta.
- Krisis identitas. Setiap remaja harus bisa melewati krisisnya serta menemukan jati dirinya. Sehingga bisa memahami dirinya sendiri, kemampuan dan kelemahan dirinya serta peranan dirinya dalam lingkungannya.
- Ikatan kelompok yang kuat. Ketidakmampuan remaja untuk menyalurkan segala keinginan dirinya membuat timbulnya dorongan yang kuat untuk berkelompok. Dalam kelompok, semua kekuatan dirinya seolah-olah dihipunkan menjadi sesuatu kekuatan yang besar.

B. Konsep Kekerasan Pada Anak & Perempuan

Makna kekerasan secara konvensional adalah apabila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental-psikologis aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya. Maksudnya perempuan yang diperlakukan dengan tindak kekerasan maka realitas jasmani dan mental-psikologis daya aktualitasnya tidak mampu merespons lingkungan. Aktualitas dirinya terdegradasi, sehingga harga diri jatuh dan keadaan jiwa yang tertekan.

Jenis kekerasan terhadap perempuan mencakup kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual, kekerasan ekonomis dan kekerasan sosial budaya. Jadi dalam konteks sosiologis kekerasan terhadap perempuan terjadi pada proses interaksi, yang menghasilkan adanya ketidak seimbangan posisi tawar dalam status peran atau kedudukan. Kondisi demikian mekanismenya ada pada struktur sosial masyarakat, yang acuannya ada dalam kultur (norma atau nilai) masyarakat dan wujudnya dalam relasi sosial atau interaksi sosial. Sehingga sumber munculnya kekerasan tersebut berkaitan dengan aspek kultural yang patriarki, aspek struktural yang dominatif, eksploitatif akibat posisi tawar laki dan perempuan tidak seimbang, sehingga realisasi jasmani dan mental-psikologis aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan pelanggaran HAM yang paling kejam. Oleh karenanya tidak salah apabila tindak kekerasan oleh organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) disebut sebuah kejahatan kemanusiaan. Serangkaian data yang dikeluarkan UNIFEM (dana PBB

untuk perempuan) tahun 2011 tentang kekerasan menunjukkan bahwa di Eropa jumlah perempuan yang mengalami kekerasan oleh pasangannya mencapai 57,9 %. Di India 49%, di Amerika Serikat 22,1 %, di Banglades 60 % dan di Indonesia masih sekitar 24 juta perempuan atau 11,4 % dari total penduduk mengalami tindak kekerasan. Kekerasan terhadap anak dari tahun ketahun juga mengalami peningkatan baik volume maupun jenis kasus.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak saja merupakan masalah individu, melainkan juga masalah nasional dan sudah menjadi masalah global. Dalam hal-hal tertentu kekerasan terhadap perempuan dapat dikatakan sebagai masalah transnasional. Dikatakan masalah global dapat dilihat dari ditetapkan hukum internasional yang menyangkut fenomena tersebut seperti ditegaskan oleh Muladi karena didasarkan pada *Viena Declaration*, wacana *Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women* (1979), *Declaration on the Elimination of Violence Against Woman* (1993) dan *Beijing Declaration and Platform for Action* (1994). Kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai masalah global, sudah mencemaskan Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, menyandang predikat buruk dalam masalah pelanggaran HAM, yang salah satu diantaranya pelanggaran HAM perempuan dan anak. Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terjadi di mana saja (di tempat umum, di tempat kerja, di lingkungan keluarga (rumah tangga) dan lain-lainnya. Dapat dilakukan oleh siapa saja (orang tua, saudara laki-laki

ataupun perempuan dan lain-lainnya dan dapat terjadi kapan saja (siang dan malam).

Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang menjadi sorotan tulisan ini yakni kekerasan terhadap perempuan dan anak yang lokusnya dalam rumah tangga dan banyak dipublikasikan melalui media. Dewasa ini kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat mencemaskan banyak kalangan terutama kalangan yang peduli terhadap perempuan. Walaupun sejak tahun 1993 sudah ada Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan namun kekerasan terhadap perempuan tetap ada dan bahkan cenderung meningkat. Hal tersebut dapat diketahui dari pemberitaan di mass media. Pada tahun 2023 lebih dari 213 kasus kekerasan perempuan dan anak menghantui masyarakat. Terlebih aksi kekerasan terhadap perempuan dan anak terkesan lebih terbuka, diekspos secara blak-blakan oleh media dan cenderung brutal ataupun sadis.

Kekerasan (*violent*) terhadap perempuan merupakan isu penting yang marak pada dewasa ini, selain mengandung aspek sosiologis, juga sarat dengan aspek ideologis. Fenomena kekerasan dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi pada sektor domestik atau urusan rumah tangga, juga terjadi di sektor publik atau lingkungan kerja, mulai dari kekerasan secara fisik sampai pada sanksi sosial atau psikologis. Timbulnya kekerasan terhadap perempuan berkaitan dengan ideologi kultural atau tata nilai yang berlaku, jenis struktur masyarakat dan pola relasional antara laki dan perempuan. Kejadiannya muncul diberbagai komunitas mulai dari desa sederhana apapun sampai pada

masyarakat kompleks kota yang modern. Kekerasan terhadap perempuan dalam perspektif sosiologis adalah mengkaji kekerasan terhadap perempuan menurut prediksi paradigma sosiologis. Ada beberapa variasi pemahaman kekerasan apabila dikaji menurut paradigma sosiologis dan sekaligus akan dipahami tingkatan analisisnya kekerasannya. Kepentingan mengkaji berbagai paradigma sosiologis dalam kekerasan mungkin dapat membantu mengeksplanasi tipe-tipe kekerasan sendiri. Kemudian mengelaborasi permasalahan dalam aspek kultur, struktur dan pola relasional.

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan nampaknya belum ada kesamaan istilah, ada yang memakai bentuk-bentuk, ada yang memakai jenis-jenis. Dalam kaitan itu penulis condong memakai bentuk-bentuk sesuai dalam U U No. 23 Tahun 2004. Kristi E. Purwandari dalam Archie Sudiarti Luhulima mengemukakan beberapa bentuk ke-kerasan terhadap perempuan dan anak dalam *headline news* beberapa media sebagai berikut: (1) Kekerasan fisik: memukul, menampar, mencekik dan sebagainya; (2) Kekerasan psikologis: berteriak, menyumpah, mengancam, melecehkan dan sebagainya; (3) Kekerasan seksual, seperti: melakukan tindakan yang mengarah keajakan/desakan seksual seperti menyentuh, mencium, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dan lain sebagainya; (4) Kekerasan finansial: mengambil barang korban, menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial dan sebagainya; (5) Kekerasan spiritual: merendahkan keyakinan dan

kepercayaan korban, memaksa korban mempraktekan ritual dan keyakinan tertentu.

Berkaitan dengan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, Sukerti dalam laporan penelitiannya di Denpasar mengatakan sebagai berikut: (1) Kekerasan fisik. Contoh: dipukul dengan tangan, dipukul dengan sendok, ditentang, dicekik, dijambak, dicukur paksa, kepala di- benturkan ke tembok; (2) Kekerasan psikologis. Contoh: diancam, di- sumpah, pendapat korban tidak pernah dihagai, dilarang bergaul, tidak pernah diajak timabang pendapat, direndahkan dengan mengucapkan kata- kata yang sifatnya merendahkan posisi perempuan; (3) Kekerasan ekonomi. Contoh: membebankan biaya rumah tangga sepenuhnya kepada per- empuan (perempuan yang bekerja secara formal) atau tidak memberikan pemenuhan finansial kepada perempuan, jadi menelantarkan rumah tangga. Kekerasan terhadap perempuan yang biasa dilangsir oleh media, biasanya berbentuk penyajian isu, berita yang dibingkai menggunakan bahasa. Bahasa ternyata dipakai untuk memahami simbol-simbol yang dapat memberikan kejelasan mengenai makna opini dan sikap atas sesuatu hal. Simbol itu dapat berupa tanda tertulis, lisan, atau gambar, yang divisualisasikan baik dalam kata-kata maupun gambar. Rakhmat (2023) menyebutkan bahwa bahasa mampu melahirkan multi interpretasi dan pemaknaan bersifat denotative maupun konotatif yang dapat mem- pengaruhi perkembangan isu tertentu.

Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi tanpa membedakan latar belakang ekonomi, pendidikan, pekerjaan, etnis, usia, lama perkawinan, atau

bentuk fisik korban. Kekerasan adalah sebuah fenomena lintas sektoral dan tidak berdiri sendiri atau terjadi begitu saja. Secara prinsip ada akibat tentu ada penyebabnya. Dalam kaitan itu Fathul Djannah mengemukakan beberapa faktornya yaitu: (1) Kemandirian ekonomi perempuan. Secara umum ketergantungan perempuan terhadap laki-laki dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan, akan tetapi tidak sepenuhnya demikian karena kemandirian perempuan juga dapat menyebabkan perempuan menerima kekerasan oleh laki-laki; (2) Karena pekerjaan perempuan. Perempuan bekerja di luar rumah dapat menyebabkan perempuan menjadi korban kekerasan; (3) Perselingkuhan laki-laki. Perselingkuhan laki-laki dengan perempuan lain atau laki-laki kawin lagi dapat melakukan kekerasan terhadap perempuan; (4) Campur tangan pihak ketiga. Campur tangan anggota keluarga dari pihak laki-laki, terutama ibu mertua dapat menyebabkan laki-laki melakukan kekerasan terhadap perempuan; (5) Pemahaman yang salah terhadap ajaran agama. Pemahaman ajaran agama yang salah dapat menyebabkan timbulnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga; (6) Karena kebiasaan laki-laki, di mana laki-laki melakukan kekerasan terhadap perempuan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan.

Sementara itu Aina Rumiati Azis mengemukakan faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan yaitu: (1) Budaya patriarki yang mendudukan laki-laki sebagai makhluk superior dan perempuan sebagai makhluk inferior; (2) Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama sehingga menganggap

laki-laki boleh menguasai perempuan; (3) Peniruan anak laki-laki yang hidup bersama ayah yang suka memukul, biasanya akan meniru perilaku ayahnya. Sukerti menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan, Sukerti sebagai berikut: (1) Karena laki-laki cemburu; (2) Laki-laki merasa berkuasa; (3) Laki-laki mempunyai selingkuhan dan kawin lagi tanpa ijin; (4) Ikut campurnya pihak ketiga (mertua); (5) Laki-laki memang suka berlaku kasar (faktor keturunan); (6) Karena laki-laki suka berjudi .

Dari beberapa faktor penyebab terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti telah disebutkan di atas faktor yang paling dominan adalah budaya patriarki. Budaya patriarki ini mempengaruhi budaya hukum masyarakat. Media yang harusnya bersikap netral terhadap realitas peng- arusutamaan *gender*, sering terjebak dalam konstruksi budaya sosial masyarakat yang bersifat patriakhi. Konstruksi budaya patriakhi dapat dilihat dari bentuk pola hubungan dan relasi yang terjadi pada laki-laki dan perempuan yang ditampilkan media. Seperti tampilan beberapa sinetron di beberapa stasiun TV, menempatkan relasi laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan dan anak, khususnya dalam distribusi peran atau pengaktoran. Perempuan dan anak lebih banyak memerankan tokoh teraniaya, tidak berdaya, objek kekerasan, komersialitas, sosok yang disia-siakan. Dalam produksi iklan, perempuan biasanya dipakai sebagai objek yang harus selalu tampil cantik, seksi dengan mengeksploitasi tubuhnya. Sedangkan iklan pada anak biasanya dituntut utuk tampil lucu dan sesuai dengan pesan atau karakter yang biasanya tidak sesuai dengan karakter si anak.

Risiko yang ditimbulkan terhadap kekerasan pada perempuan meliputi;

1. HIV dan infeksi menular seksual lainnya.

Selama satu dekade terakhir, ada telah berkembang bahwa kekerasan pasangan intim merupakan kontributor penting dalam kerentanan perempuan terhadap HIV dan IMS. Mekanisme yang mendasari kerentanan wanita terhadap HIV atau IMS adalah hubungan seksual secara paksa.

Perempuan dalam hubungan kekerasan, atau yang hidup dalam ketakutan kekerasan, juga mungkin memiliki kontrol terbatas atas waktu atau keadaan dari hubungan seksual, atau kemampuan mereka untuk menegosiasikan penggunaan kondom.

2. ABORSI

Perilaku kekerasan terhadap perempuan berdampak besar pada kesehatan seksual dan reproduksi perempuan serta penggunaan kontrasepsi seperti kondom. Ketidakmampuan perempuan untuk menolak paksaan laki-laki dalam penggunaan kondom mengakibatkan kelahiran yang tidak diinginkan, diperkirakan dari 80 juta kehamilan yang tidak diinginkan setiap tahun, setidaknya setengah dihentikan melalui aborsi dan hampir setengah dari mereka berlangsung dalam kondisi aborsi yang tidak aman. Kehamilan yang tidak diinginkan dilakukan dengan risiko bagi ibu dan bayi karena aborsi ilegal dan risiko kematian akan mengancam.

3. Berat Badan Lahir Rendah Dan Prematur

Berat badan lahir rendah dan kelahiran prematur atau pembatasan pertumbuhan dalam rahim sangat berhubungan dengan stres dan

lingkungan yang tidak mendukung yang berakibat pada tingkat stres kronis menjadi faktor risiko utama kesehatan ibu dan akan mempengaruhi janin, studi observasional yang dilakukan untuk menyelidiki kekerasan pada pasangan intim berpotensi mengakibatkan bayi lahir berat rendah serta lahir prematur.

4. Penggunaan Alkohol yang Obat Berbahaya

Berat badan lahir rendah dan kelahiran prematur atau pembatasan pertumbuhan dalam rahim sangat berhubungan dengan stres dan lingkungan yang tidak mendukung yang berakibat pada tingkat stres kronis menjadi faktor risiko utama kesehatan ibu dan akan mempengaruhi janin, studi observasional yang dilakukan untuk menyelidiki kekerasan pada pasangan intim berpotensi mengakibatkan bayi lahir berat rendah serta lahir prematur.

5. Depresi dan Bunuh Diri

Kekerasan pasangan intim dapat menyebabkan depresi dan usaha bunuh diri serta peristiwa traumatis karena kekerasan seksual sehingga perempuan akan menjadi depresi memungkinkan terjadi perilaku bunuh diri. penelitian lain menunjukkan bahwa wanita dengan masalah kesehatan mental akibat kekerasan seksual sering akan mengakhiri hidupnya.

6. Luka Non-Fatal

kekerasan pasangan intim dikaitkan dengan banyak konsekuensi kesehatan, tetapi efek yang langsung cedera adalah fatal dan non-fatal. diperkirakan bahwa sekitar setengah dari wanita di

Amerika Serikat yang terluka secara fisik dengan pasangan mereka, sebagian besar dari mereka masih terlihat bekas luka di bagian Kepala, leher dan wajah akibat kekerasan pasangan mereka, diikuti oleh cedera otot dan cedera genital. Pengukuran cedera akibat kekerasan pasangan intim tetap menantang karena berbagai alasan.

7. Cedera Fatal (Kasus Pembunuhan Pasangan Intim)

pembunuhan baik pria atau wanita lebih banyak disebabkan karena pasangan intim mereka, dalam hal ini pasangan intim wanita yang paling banyak dibunuh. di Indonesia data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang terkumpul tersebut jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol sama seperti tahun sebelumnya adalah KDRT/RP yang mencapai angka 11.207 kasus (69%). Pada ranah KDRT/RP kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 4.304 kasus (38%), menempati peringkat pertama disusul kekerasan seksual 3.325 kasus (30%), psikis 2.607 kasus (23%) dan ekonomi 971 kasus (9%). Kekerasan di ranah komunitas mencapai angka 5.002 kasus (31%), di mana kekerasan seksual menempati peringkat pertama sebanyak 3.174 kasus (63%), diikuti kekerasan fisik 1.117 kasus (22%) dan kekerasan lain di bahwa angka 10%; yaitu kekerasan ekonomi 64 kasus (1%), buruh migran 93 kasus (2%); dan trafiking 378 kasus (8%).

Secara umum, jumlah pengaduan kasus menurun pada tahun 2022 dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi 457.895 dari 459.094. Penurunan pelaporan dihimpun dari data lembaga layanan dan Badilag. Sementara

pengaduan ke Komnas Perempuan meningkat menjadi 4371 dari 4322 kasus. Dengan jumlah ini berarti rata-rata Komnas Perempuan menerima pengaduan sebanyak 17 kasus /hari.,Sebanyak 339.782 dari total pengaduan tersebut adalah kekerasan berbasis gender (KBG), yang 3442 di antaranya diadukan ke Komnas Perempuan. Kekerasan di ranah personal masih mendominasi pelaporan kasus KBG, yaitu 99% atau 336.804 kasus. Pada pengaduan di Komnas Perempuan, kasus di ranah personal mencapai 61% atau 2.098 kasus. Untuk kasus di ranah publik, tercatat total 2978 kasus dimana 1.276 di antaranya dilaporkan kepada Komnas Perempuan. Sementara itu, kasus kekerasan di ranah negara hanya ditemukan di Komnas Perempuan, dengan peningkatan hampir 2 kali lipat, dari 38 kasus di 2021 menjadi 68 kasus di 2023.

Tingkat respon pengembalian formulir Catahu naik sebesar 25% (137 lembaga) jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 18% (129 lembaga) dari total formulir yang dikirimkan.

Data pengaduan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2023 menunjukkan kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dominan (2.228 kasus/38.21%) diikuti kekerasan psikis (2.083 kasus/35,72%). Sedangkan data dari lembaga layanan didominasi oleh kekerasan dalam bentuk fisik (6.001 kasus/38.8%), diikuti dengan kekerasan seksual (4102 kasus/26.52%%). Jika dilihat lebih terperinci pada data pengaduan ke Komnas Perempuan di ranah publik, kekerasan seksual selalu yang tertinggi (1.127 kasus), sementara di ranah personal yang terbanyak kekerasan psikis (1.494). Berbeda dengan lembaga layanan, data

tahun 2023 ini menunjukkan bahwa di ranah publik dan personal yang paling banyak berbentuk fisik.

Data pengaduan ke Komnas Perempuan dibagi menjadi 3 ranah; ranah personal terdapat 2098 kasus, ranah publik 1276 kasus dan ranah negara 68 kasus.

Ada perbedaan perlakuan penggunaan bahasa yang digunakan pada editorian atau naskah berita, dengan menyebut korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Seperti ketika ada korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas jalan raya pada perempuan dan anak. Bahasa yang dipergunakan pada korban perempuan seperti kata “perempuan na’as”, pada korban pemerkosaan sering menggunakan bahasa “digarap, digilir, dikerjai”. Pada kekerasan domestik sering menggunakan bahasa “digasak, dipenggal, dan kata-kata berkonotasi negatif lainnya.” Pada korban laki-laki biasanya banyak menggunakan kata atau struktur bahasa yang jauh lebih halus seperti dibunuh, dianiaya, dan lain sebagainya. Perbedaan perlakuan dalam penggunaan bahasa dalam media dipercaya mampu melanggengkan dominasi laki-laki atas perempuan terhadap peran sosial yang berlaku di masyarakat.

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat berakibat buruk terutama terhadap si korban dan anak-anak yakni dapat berpengaruh terhadap kejiwaan korban dan perkembangan kejiwaan anak dan juga berdampak pada lingkungan sosial. Di samping itu dampak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga yaitu dampak medis, seperti memerlukan biaya pengobatan. Dampak emosional seperti depresi, penyalahan obat-obatan dan alkohol,

setres pasca trauma, rendahnya kepercayaan diri. Dampak pribadi seperti anak-anak yang hidup dalam lingkungan kekerasan berpeluang lebih besar bahwa hidupnya akan dibimbing oleh kekerasan, anak yang menjadi saksi kekerasan akan menjadi trauma termasuk di dalam perilaku anti sosial dan depresi.

Media juga berperan dalam merepresentasikan faktor penyebab serta dampak kekerasan menurut opini dan ideologi yang diusung media. Selanjutnya, proses ini dapat mempengaruhi kebijakan dan strategi penyelesaian tindak kekerasan khususnya terhadap perempuan dan anak. Meski media bersikap netral, fakta yang ditampilkan dalam pemberitaan mengkonstruksi perempuan dan anak sebagai individu atau kelompok yang menjadi kaum suborninat dan korban tindak kekerasan. Namun disayangkan media masih memiliki kontribusi yang minim terhadap penanganan kekerasan perempuan dan anak. Berkaitan dengan hal ini, maka keberadaan media atas fenomena kekerasan perempuan dan anak memainkan peran strategis pengarus utamaan gender, dan selanjutnya dapat mengurangi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga kesetaraan peran dan kedudukan perempuan dan anak dapat setara.

Selain pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan, korban kekerasan, pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan juga adalah hal penting karena merupakan upaya yang perlu ditangani secara lintas program dan lintas sektoral, dengan keterlibatan secara aktif LSM dan anggota masyarakat sebanyak mungkin. Mengakhiri kekerasan terhadap perempuan memerlukan komitmen jangka

panjang dari pihak-pihak yang berperan. Sektor kesehatan perlu memulai upaya ini agar dapat berkontribusi dalam pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan di tingkat layanan dasar. Sistem pelayanan kesehatan mempunyai posisi strategis untuk mengenali dan memberikan pertolongan kepada korban. Perempuan pada umumnya dapat mengunjungi fasilitas atau petugas kesehatan, untuk mendapatkan pelayanan kebidanan, pelayanan KB, atau pelayanan kesehatan lainnya untuk dirinya atau anaknya.

Terlepas dari strategisnya peranan dari tenaga kesehatan, hasil penelitian dari menunjukkan adanya petugas kesehatan di lapangan yang kurang atau bahkan belum responsif dan tidak berusaha menggali informasi bila penderita perempuan datang dengan tanda-tanda kekerasan. Akibatnya korban kekerasan seringkali terabaikan dan tidak memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. Hal ini mungkin karena petugas belum memahami masalahnya dan belum mengetahui cara menanganinya. Seharusnya, tenaga Kesehatan umumnya khususnya bidan dan Obsginsos dapat memainkan peran yang sangat penting dalam menghadapi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Pertolongan sedini mungkin dapat mencegah terjadinya masalah kesehatan yang serius dan berlarut-larut. Dengan dukungan dan pelatihan dari sistem pelayanan kesehatan, petugas kesehatan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pelayanan secara fisik, emosi dan rasa aman dari korban kekerasan.

Untuk dapat melaksanakan fungsi dan peranannya dalam mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan dan penanganan korban, terdapat berbagai

kemampuan yang harus dimiliki oleh tenaga kesehatan. Disarikan dari hasil penelitian Utami dan Yuhartati, beberapa kemampuan yang diperlukan tersebut misalnya: (a) memahami masalah kekerasan terhadap perempuan dan ketidakberdayaan korban, yang berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi perempuan dan kemampuannya dalam pengambilan keputusan, (b) dapat memberikan penyuluhan yang tepat dan meyakinkan perempuan bahwa berbagai bentuk penyalahgunaan atau kekerasan terhadap pasangan tidak dapat diterima, dan karenanya tidak ada perempuan yang pantas untuk dipukul, dipaksa dalam berhubungan seksual atau didera secara emosional, (c) dapat melakukan anamnesis tentang kekerasan yang dialami dengan baik secara simpatik, sehingga korban merasa mendapat pertolongan, (d) dapat memberikan rasa empati dan dukungan terhadap korban, (e) dapat memberikan pelayanan medis, konseling, visum dan sesuai dengan kebutuhan merujuk ke fasilitas yang memadai dengan cepat dan tepat, (f) memberikan pelayanan Keluarga Berencana dan pelayanan kesehatan reproduksi lainnya sesuai dengan kebutuhan, serta mencegah dampak serius terhadap kesehatan reproduksi korban, (g) dapat mengidentifikasi korban kekerasan dan dapat menghubungkan mereka dengan pelayanan dukungan masyarakat lainnya misalnya politik LSM dan bantuan lainnya, serta (h). memberi perlindungan bagi korban atau saksi dari kekerasan, serangan pembalasan atau stigmatisasi.

Sebagaimana pemaparan di atas, masih sering ditemukan petugas kesehatan yang kurang peka terhadap kemungkinan adanya tindak kekerasan yang

terjadi pada perempuan yang datang ke pusat pelayanan. Hal ini tentu saja menghambat proses penanganan sehingga seringkali terlambat dan masalahnya sudah semakin pelik atau bahkan sudah memakan korban. Mengenai hal ini, beberapa hasil penelitian di Indonesia menyimpulkan adanya beberapa faktor yang membuat hal ini bisa terjadi di berbagai tempat di Indonesia seperti kurangnya pemahaman dan keterampilan petugas kesehatan, *stereotype* budaya, sikap sosial yang negatif dan kendala institusional.

Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut oleh Utami, temuan dalam penelitian yang dilakukannya terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga di daerah Jogjakarta menunjukkan bahwa kurangnya keterampilan teknis dan sumberdaya dari petugas kesehatan seringkali menyebabkan petugas kesehatan cenderung tidak menanyakan tentang kekerasan yang dialami oleh penderita. Hal ini bisa saja terjadi karena si petugas merasa tidak siap dalam memberikan pelayanan atau merasa tidak mempunyai waktu dan sumberdaya untuk menolong korban kekerasan. Selain itu, faktor lain yang menyebabkan keengganan petugas untuk mencari informasi lebih dalam adalah karena khawatir akan melukai perasaan dan menganggap hal tersebut merupakan masalah pribadi.

Keadaan ini seringkali diperparah oleh adanya *stereotype* budaya dan sikap sosial yang negatif. Dalam kenyataan di lapangan, petugas kesehatan seringkali menerapkan nilai-nilai sosial dan sikap masyarakat tentang penyalahgunaan atau kekerasan terhadap pasangan yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Dengan demikian mereka mungkin menganggap bahwa

kelompok perempuan tertentu pantas untuk dikerasi atau harus selalu siap melayani kebutuhan seksual suami setiap saat. Sering kali pula kekerasan dianggap biasa pada kalangan miskin, etnik atau agama tertentu. Kadang-kadang petugas kesehatan perempuan juga mengalami kekerasan domestik, yang akan menjadi hambatan bagi dirinya dalam membicarakan kekerasan terhadap perempuan dan kemampuannya dalam memberikan pertolongan. Selain itu, Widiastuti juga mengungkapkan adanya keengganan korban mengemukakan kekerasan yang dialaminya. Banyak perempuan yang enggan mengemukakan secara langsung tentang kekerasan yang dialaminya karena malu, ketergantungan ekonomi terhadap pasangan, takut dipersalahkan atau takut berurusan dengan polisi sementara tetap tak ada jaminan untuk perlindungan dari tindak kekerasan pasangannya. Banyak diantaranya yang juga dibatasi mobilitasnya oleh pasangan yang melakukan tindak kekerasan, sehingga bila ke fasilitas kesehatan selalu didampingi. Kehadiran si pelaku tindak kekerasan ini bisa menyebabkan si korban jadi tidak bisa dan tidak mau berterus terang kepada pihak yang terkait.

Terlepas dari faktor personal dan sosial, kendala lain yang sering timbul dalam penanganan tindak kekerasan pada perempuan adalah hambatan secara institusional. Afandi menjelaskan bahwa kurangnya penghargaan dalam penanganan korban bila dibandingkan pelayanan medis lainnya dan ketakutan akan terlibat sebagai saksi dalam proses pengadilan cenderung membuat petugas kesehatan menjadi enggan untuk terlibat lebih lanjut. Tambahan lagi,

kurangnya dukungan institusi dalam penanganan kasus merupakan kendala yang seringkali dihadapi oleh petugas yang menangani kasus seperti ini. Selain itu, keterbatasan rujukan dan kurangnya koordinasi antar fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk pemberian kontrasepsi emergensi dan skrining terhadap penyakit menular seksual bagi korban untuk mendapatkan pelayanan yang dibutuhkannya juga menjadi masalah yang seringkali terjadi di lapangan.

Berbagai kendala yang banyak dihadapi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan membuat hal ini masih menjadi tantangan berat bagi para pemangku pemerintahan di Indonesia. Karenanya, berbagai strategi dan upaya harus juga terus ditingkatkan dalam rangka meminimalisir tindak kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan oleh Syufri dan Juita, ada beberapa yang dapat dilakukan oleh petugas kesehatan dalam upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan. Terdapat beberapa kelompok yang bisa dijadikan sasaran upaya ini berdasarkan kategori usia, yaitu kelompok dewasa, kelompok remaja, dan kelompok anak.

Beberapa upaya yang mungkin dilaksanakan pada kelompok usia dewasa juga disarankan seperti sarasehan dan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak serta menolak kekerasan sebagai cara untuk memecahkan masalah, penyuluhan tentang prevalensi kekerasan dan akibatnya bagi keluarga dan masyarakat, promosi sikap mendukung dan tak menyalahkan korban melalui berbagai media, memasukkan materi tentang kekerasan fisik dan seksual terhadap perempuan ke

program radio/televisi, termasuk drama sosial yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, mengupayakan adanya materi pengenalan dan pembelajaran yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, mempromosikan kesehatan jender melalui penampilan perempuan yang berdaya dan pasangan laki-laki yang melindungi, kampanye untuk pencegahan penyalahgunaan obat dan alkohol, serta mendukung pendidikan tentang hak asasi manusia dan berbagai cara untuk memberdayakan perempuan.

Selain pada kelompok dewasa yang merupakan target utama, kelompok remaja dan anak juga perlu dilibatkan dalam upaya pencegahan ini. Beberapa tindakan yang bisa dilakukan misalnya melalui pendidikan tentang kesehatan reproduksi remaja yang meliputi norma jender dan pencegahan perilaku seksual yang membahayakan, pembahasan mengenai bahaya seks bebas dan hubungan laki-laki dan perempuan, cinta, cemburu dan kekerasan, serta pendidikan hak perempuan bagi remaja putri. Selain itu, bagi anak-anak dalam golongan usia lebih muda, bisa juga diupayakan untuk mendukung pendidikan melalui sekolah dan luar sekolah tentang ketrampilan dalam menghadapi masalah sehari-hari, termasuk mengatasi konflik, membangun hubungan interpersonal yang sehat dan keamanan diri serta mengendalikan emosi dan kemarahan. Selain itu, kampanye anti-kekerasan, misalnya dengan promosi: "Tangan bukan untuk memukul!".

C. Aspek Legal Hukum Tentang Perlindungan Anak & Perempuan

KTP (kekerasan Terhadap Perempuan) merupakan setiap tindakan yang berakibat atau mungkin mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, psikis, atau seksual, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.

Berdasarkan Rekomendasi Umum Nomor 19 Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan Tahun 1992 tentang Kekerasan terhadap Perempuan ayat 6, Kekerasan berbasis gender yaitu kekerasan yang langsung ditujukan terhadap seorang perempuan karena dia adalah perempuan atau hal-hal yang memberi akibat pada perempuan secara tidak proporsional. Hal tersebut termasuk tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental, seksual, atau ancaman-ancaman seperti itu, paksaan, dan perampasan kebebasan lainnya. Kekerasan berbasis gender bisa melanggar ketentuan tertentu dari Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, walaupun ketentuan itu tidak menyatakan secara spesifik adanya kekerasan.

Bentuk-bentuk kekerasan di Tempat Kerja merupakan pengkategorian kekerasan berdasarkan sasaran kekerasan yang dilakukan, yang mencakup fisik, psikologis/mental, seksual, dan penelantaran ekonomi.

1. Kekerasan fisik

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan fisik didefinisikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang menjadikan tubuh perempuan sebagai sasarannya, misalnya memukul, menusuk, menjambak, meninju, menampar, atau menendang.

2. Kekerasan seksual

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas:

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. pelecehan seksual fisik;
- c. pemaksaan kontrasepsi;
- d. pemaksaan sterilisasi;
- e. pemaksaan perkawinan;
- f. penyiksaan seksual;
- g. eksploitasi seksual;
- h. perbudakan seksual; dan
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain itu, tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi:

- a. perkosaan;
- b. perbuatan cabul;
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;

- e. pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kekerasan psikis

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan psikis didefinisikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikologis dapat muncul dalam bentuk ucapan-ucapan menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, penghinaan, atau ancaman. Hal ini akan terus terbawa dalam jangka waktu yang sangat lama, dapat merusak harga diri, menimbulkan kebingungan, bahkan menyebabkan masalah-masalah psikologis serius pada perempuan korban.

4. Pelanggaran hak maternitas

Pelanggaran hak maternitas misalnya seperti keguguran di Tempat Kerja tidak dianggap kecelakaan kerja, tidak ada fasilitas bagi ibu hamil,

ruang laktasi, dan kesempatan perah air susu ibu (ASI) bagi pekerja yang menyusui. Selain itu, sulitnya mendapat cuti haid dan tidak ada tunjangan bagi buruh yang hamil dan melahirkan.

Dampak Dari Kekerasan Di Tempat Kerja Dalam hal tindakan kekerasan terhadap Pekerja/Buruh dan Pegawai perempuan di Tempat Kerja meliputi banyak aspek yang bisa mempengaruhi satu sama lain.

5. Dampak bagi korban

- a. secara fisik, mengalami sakit baik tingkat sedang sampai berat dan mempengaruhi performa kerja;
- b. secara psikis, mengalami stres, gangguan tidur, depresi, sampai dengan ekspresi trauma;
- c. produktivitas dan performa kerja menurun;
- d. merasa terkunci dalam Tempat Kerja; dan
- e. Mempengaruhi interaksi antar sesama Pekerja/Buruh dan Pegawai perempuan.

6. Dampak bagi Perusahaan

atau Tempat Kerja Konsekuensi dari dampak individual yang telah disebutkan di atas bagi Perusahaan menyebabkan hal-hal berikut:

- a. meningkatnya pembiayaan rekrutmen, orientasi dan pelatihan bagi pekerja akibat dari pekerja yang berhenti/diterima;
- b. menurunnya solidaritas antar tim kerja dan hubungan interpersonal sehingga mempengaruhi performa kerja;
- c. Tempat Kerja yang tidak nyaman, aman, dan ramah sehingga akan menurunnya produktivitas tenaga kerja dan pada akhirnya dapat menurunkan keuntungan Perusahaan atau Tempat Kerja; dan
- d. citra Perusahaan atau Tempat Kerja menjadi buruk sehingga kehilangan kepercayaan publik dan

masyarakat yang akan mempengaruhi hubungan kemitraan dalam upaya pengembangan kapasitas dan performa perusahaan atau tempat kerja.

BAB 3

PERILAKU SEKSUAL PRANIKAH & PERNIKAHAN USIA DINI

A. Perilaku Seksual Pranikah

Kata pranikah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2022:93), berasal dari kata “pra” berarti “sebelum”, sedangkan “nikah” berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi. Secara umum “pranikah” didefinisikan sebagai hal yang terjadi sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi. Sarwono (2022:142) mendefinisikan perilaku seksual pranikah adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis. Perilaku ini dilakukan sebelum menikah atau pada saat pacaran. Sementara itu, Soetjiningsih (2022:1) mengatakan perilaku seksual pranikah pada remaja adalah segala tingkah laku seksual yang didorong oleh hasrat seksual dengan lawan jenisnya, yang dilakukan remaja sebelum mereka menikah. Menurut Simanjuntak (2022:29) perilaku seksual pranikah adalah segala macam tindakan, seperti bergandengan tangan, berciuman, bercumbu, sampai dengan bersenggama yang dilakukan karena adanya dorongan hasrat seksual yang dilakukan sebelum adanya ikatan pernikahan.

Sementara itu, Ariyandini (2022:04) mengatakan perilaku seksual pranikah adalah perilaku yang didorong oleh hasrat seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan

perempuan mulai dari berkencan, bercumbu, sampai besenggama tanpa adanya ikatan pernikahan yang resmi berdasarkan agama dan hukum. Berdasarkan berbagai konsep di atas, maka perilaku seksual pranikah dapat diartikan sebagai tingkah laku yang berhubungan dengan dorongan seksual dengan lawan jenis maupun sesama jenis yang dilakukan sebelum adanya ikatan pernikahan yang sah baik secara hukum maupun agama.

Kategori Perilaku Seksual Pranikah Menurut Sarwono, (2022:166) seks pranikah terdiri dari: Berpegangan tangan, berpelukan, berciuman, meraba payudara, meraba alat kelamin, dan bersenggama. Sedangkan menurut Soetjningsih (2022:1) terdapat beberapa tahap perilaku seksual pranikah pada remaja, yaitu: Berpegangan tangan, memeluk atau dipeluk dibahu, memeluk atau dipeluk dipinggang, ciuman bibir, ciuman bibir sambil pelukan, meraba atau diraba daerah erogen dalam keadaan berpakaian, saling menempelkan alat kelamin dalam keadaan berpakaian, meraba atau diraba daerah erogen dalam keadaan tanpa berpakaian, mencium atau dicium daerah erogen dalam keadaan tanpa berpakaian, saling menempelkan alat kelamin dalam keadaan tanpa berpakaian, dan berhubungan badan. Firminia (2022:241) mengatakan beberapa tahap perilaku seksual pranikah yaitu: Berpegangan, berpelukan, cium pipi, berciuman/kissing, bercumbu ringan, bercumbu berat, dan hubungan seks sebelum waktunya. Anesia dan Notobroto (2023:142) menyebutkan tahap perilaku seksual pranikah yaitu: Berpegangan tangan, berpelukan, cium pipi, ciuman bibir, meraba daerah sensitif tubuh, mendekatkan alat kelamin (petting), dan hubungan seks.

Perilaku seksual yang terjadi dikalangan remaja menurut Sarwono, (2022:154-154) dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Perubahan-perubahan hormonal Perubahan hormonal dapat meningkatkan hasrat seksual (libido seksual) remaja. Meningkatnya hasrat seksual ini membutuhkan penyaluran dalam bentuk tingkah laku seksual tertentu. Dalam penyaluran inilah mereka melakukan hal-hal yang semestinya tidak mereka lakukan seperti: berpegangan tangan, pelukan, berciuman, meraba payudara, meraba alat kelamin, dan bahkan sampai melakukan hubungan seks layaknya suami-istri untuk memenuhi hasrat seksual yang bergejolak didalam diri mereka.
2. Penundaan usia perkawinan Penyaluran hasrat seksual tidak dapat segera dilakukan karena adanya penundaan usia perkawinan, baik secara hukum oleh karena adanya undang undang tentang perkawinan yang menetapkan batas usia menikah (sedikitnya 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria), maupun karena norma sosial yang makin lama semakin menuntut persyaratan yang tinggi untuk perkawinan (pendidikan, pekerjaan, kesiapan mental, dan lain-lain).
3. Lemahnya kemampuan mengendalikan dorongan seksual Sementara usia perkawinan ditunda, norma-norma agama tetap berlaku dimana seseorang dilarang untuk melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Bahkan, larangannya berkembang lebih jauh kepada tingkah laku yang lain seperti melakukan masturbasi. Untuk remaja yang tidak dapat menahan diri akan terdapat kecenderungan untuk melanggar larangan tersebut.

4. Kurangnya informasi tentang seks Remaja pada umumnya belum pernah mengetahui masalah seksual secara lengkap baik dari orang tua maupun gurunya di sekolah. Jarang ada sekolah yang memberikan pendidikan seksual kepada anak didiknya baik karena tidak tahu cara menginformasikannya maupun juga karena takut jika akibatnya malah membuat remaja semakin ingin tahu. Remaja yang sedang berada dalam periode keingintahuan yang tinggi justru malah mencari sendiri informasi tentang seks tersebut, yang pada akhirnya mereka mendapatkan informasi yang tidak benar dan tidak terkontrol yang akibatnya informasi tersebut menggiring mereka untuk melakukan perbuatan asusila.
5. Kurangnya komunikasi antara orang tua dengan anak. Orang tua sendiri, baik karena ketidaktahuannya maupun karena sikapnya yang masih menabukan pembicaraan mengenai seks dengan anak dan tidak terbuka terhadap anak, malah cenderung membuat jarak dengan anak dalam masalah seks itu sendiri. Akibatnya anak menjadi malu dan takut untuk membicarakan dan menanyakan hal seputar seks tersebut kepada orangtuanya. Padahal pendidikan seks pada remaja merupakan hal yang penting untuk mereka peroleh. Karena dengan memberikan pengetahuan yang benar kepada remaja seputar masalah seksualitas ini diharapkan mereka memiliki pemahaman tentang dampak yang akan ditimbulkan dari perilaku tersebut, baik dampak pada diri sendiri maupun dampak bagi orang lain.
6. Pergaulan yang semakin bebas. Kebebasan pergaulan antar jenis kelamin seperti yang terjadi pada remaja

saat sekarang, sangat memberikan sumbangsih yang besar terhadap terjadinya perilaku seks pranikah. Karena semakin bebasnya mereka bergaul dengan siapa saja termasuk juga dengan lawan jenis, maka hal itu akan memberi peluang remaja untuk melakukan seks pranikah. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengawasan dan kontrol dari orangtua, termasuk juga dari masyarakat, sehingga mereka bebas bergaul dengan siapa saja dan bebas melakukan apa saja yang diinginkan.

Sementara itu menurut Kartono (2022) bahwa perilaku seksual pada remaja umumnya disebabkan oleh disharmoni dalam kehidupan psikisnya, yang ditandai dengan:

1. Bertumpuknya konflik-konflik batin,
2. Kurangnya rem-rem terhadap nafsu-nafsu hewani,
3. Kurang berfungsinya kemauan dan hati nurani,
4. Kurang tajamnya intelek untuk mengendalikan nafsu seksual yang bergelora.

Selanjutnya Harlock (2022:226) menyatakan bahwa manifestasi dorongan seksual dalam perilaku seksual dipengaruhi oleh:

1. Faktor internal, yaitu stimulus yang berasal dari dalam diri individu yang berupa bekerjanya hormon-hormon alat reproduksi sehingga menimbulkan dorongan seksual pada individu yang bersangkutan dan hal ini menuntut untuk segera dipuaskan.
2. Faktor eksternal, yaitu stimulus yang berasal dari luar individu yang menimbulkan dorongan seksual sehingga memunculkan perilaku seksual. Stimulus eksternal tersebut dapat diperoleh melalui pengalaman kencan, informasi mengenai seksualitas, diskusi dengan teman,

pengalaman masturbasi, jenis kelamin, pengaruh orang dewasa, serta pengaruh buku bacaan dan tontonan porno.

Sementara itu, Taufik (2023:32-33) menyebutkan dampak dari perilaku seks pranikah, yaitu:

1. Menciptakan kenangan buruk pada remaja
2. Mengakibatkan kehamilan
3. Terjadi pengguguran kandungan/aborsi
4. Terjangkit penyakit kelamin
5. Perasaan bersalah
6. Perasaan takut ditinggal pacar
7. Timbul rasa ketagihan pada remaja yang melakukan seks tersebut.

B. Pernikahan Usia Dini

1. Pengertian Pernikahan Dini

United Nations Children's Fund (UNICEF) berpendapat pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun (UNICEF, 2022).

Pernikahan dini mengacu pada pernikahan yang terjadi pada perempuan yang usianya belum mencapai 20 tahun dan laki-laki belum mencapai 25 tahun atau pernikahan tersebut melibatkan satu atau dua pihak yang masih anak-anak (BKKBN, 2022). Pernikahan dini adalah pasangan suami istri melangsungkan pernikahan dibawah umur 20 tahun yang dimana adalah masa remaja dan masa pertumbuhan organ reproduksinya belum matang.(Sugiarti, 2022)

2. Faktor penyebab pernikahan dini

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan (Anjarwati, 2022) didapatkan nilai p value sebesar 0.006 ($p < 0,005$) mengungkapkan bahwa meningkatnya

pernikahan dini sebagian besar disebabkan oleh kehamilan yang tidak diinginkan dimana hal tersebut mengarah pada meningkatnya tingkat perceraian. Gage, (2021) faktor yang mendasari praktek pernikahan dini diantaranya norma-norma budaya, kemiskinan, keterbatasan ekonomi, dan pendidikan yang terbatas dan kekhawatiran orangtua dalam menjaga keperawanan putri mereka.

Ada beberapa faktor faktor yang memicu terjadinya pernikahan usia dini meliputi:

a. Pengetahuan

Berdasarkan penelitian yang ditemukan (Dwinanda et al., 2022) didapatkan (p Value <0,05, Or = 4,268) menyatakan bahwa responden yang memiliki pengetahuan rendah mengenai pernikahan usia dini memiliki risiko untuk melakukan pernikahan dini. Penyebab kurangnya pengetahuan remaja putri tersebut dikarenakan sebagian besar dari remaja putri berpendidikan menengah serta umur mereka yang masih dibawah 20 tahun menyebabkan pola pikir mereka masih belum matang dan dewasa dalam menerima informasi yang diberikan dan juga mengambil keputusan.

b. Pendidikan

Menurut (Godha, Hotchkiss dan Gage, 2023) berdasarkan beberapa penelitian menunjukkan korelasi yang kuat antara pendidikan dan usia saat perkawinan. Anak yang pendidikannya rendah dan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi cenderung menjadikannya tidak produktif dan terdorong untuk cepat- cepat menikah tanpa memikirkan dampak yang akan ditimbulkan dari

keinginannya untuk menikah. Orang tua yang juga memiliki pendidikan rendah cenderung memiliki pola pikir yang pasrah dan menerima. Hal yang demikian berdampak pada orientasi yang sempit pemahaman tentang adanya UU Perkawinan serta dampak fisiologis yang akan dihadapi setelah menikah, yang dimana pendidikan orang tua maupun pendidikan remaja merupakan faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini (Oktavia et al., 2022).

c. Status ekonomi

Rosilayati, R. et al., 2022) didapatkan dengan presentase 20% yaitu ekonomi melatar belakangi orang tua memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan akan mengurangi beban finansial dalam keluarga karena, ketika anaknya menikah maka kehidupan sang anak ditanggung oleh sang suami. Hal ini banyak ditemukan di Pedesaan dengan tidak memperhatikan usia yang masih dini.

d. Pergaulan bebas

Berdasarkan penelitian (Rahawa & Mouliza, 2022) Didapatkan nilai ($p < 0,05$) dengan responden yang sebaian besar pergaulan tidak baik sebanyak (63,5%) sehingga Kurangnya kontrol sosial dari lingkungan masyarakat sehingga mereka menganggap bahwa apapun yang dilakukan oleh muda mudi yang berpacaran adalah hal biasa meskipun terkadang pergaulan mereka sudah melewati batas.

e. Media masa

Remaja putri yang terpapar oleh media massa yang berbau pornografi baik itu awalnya disengaja atau tidak disengaja. Pada umumnya, gambar-gambar maupun video yang berbau porno tersebut banyak

diperoleh dari media sosial. Rata-rata remaja putri mengakses situs-situs yang berbau porno dari hand phone mereka sendiri. Setelah melihat gambar ataupun video porno tersebut, remaja putri terdorong untuk mencoba apa saja yang telah dilihatnya termasuk yang berkaitan dengan masalah seksualitas, pada akhirnya dapat menyebabkan remaja putri tersebut menjadi hamil. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemantauan dari orang tua serta kurangnya pengetahuan remaja putri tentang seks pra nikah. Oleh karena itu dibutuhkan peran keluarga untuk memantau dan mendampingi anaknya dalam penggunaan media massa baik media cetak, elektronik, internet (terutama media sosial) agar tidak terpapar dengan gambar, video serta situs-situs porno, serta orang tua dapat memberikan penjelasan pada anak terkait kesehatan reproduksinya termasuk masalah seks sehingga anak memiliki informasi tentang seks secara lengkap dari orang tuanya dan pada akhirnya ia tidak perlu lagi mencari informasi yang berkaitan dengan seks dari media massa. (Prabantari, I., 2022).

f. Budaya

Budaya yang dipercayai oleh masyarakat diantaranya adalah anak perempuan yang menikah di atas 0 tahun makan akan menjadi perawan tua, serta jika terlambat menikah akan menjadi aib bagi keluarga. Maka tidak heran apabila ada wanita yang lama menikah (usia > 20 tahun) akan dijadikan sebagai bahan pembicaraan dimasyarakat. Karena takut dicemooh oleh masyarakat maka banyak menikah dibawah usia 20 tahun. Budaya tersebut dipercayai

oleh remaja putri karena kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. (Hardianti, R., Dkk, 2020).

1) Dampak pernikahan dini

- a. Dampak positif pernikahan dini Dengan melakukan pernikahan dini akan memberikan dampak positif bagi pasangan tersebut. Diantaranya adalah :

(1) Dukungan emosional

Dengan dukungan emosional maka dapat melatih kecerdasan emosional dan spiritual dalam diri setiap pasangan.

(2) Dukungan keuangan

Dengan menikah diusia dini dapat meringankan beban ekonomi menjadi lebih menghemat.

(3) Kebebasan yang lebih

Dengan berada jauh dari rumah maka akan menjadikan mereka bebas melakukan hal sesuai keputusannya untuk menjalani hidup mereka secara finansial dan emosional.

b. Dampak negative pernikahan dini

Meskipun menikah memiliki dampak positif, tidak dapat dipungkiri bahwa menikah juga berdampak negative pada pasangannya terdapat dalam berbagai aspek diantaranya yaitu:

(1) Aspek ekonomi

bertanggung jawab untuk menafkai mereka. (Dina M,L., 2023)

(2) Aspek psikologis

Dampak secara psikologis usia remaja kejiwaannya belum sepenuhnya matang. Dalam masa peralihan dari anak ke remaja dipengaruhi oleh perubahan hormonal yang membuat emosi berubah- rubah, cenderung dinih marah dan dinih tersinggung (BKKBN, 2012). Remaja belum memiliki pengetahuan tentang bagaimana menjalankan peran sebagai seorang ibu dan istri sehingga pernikahan usia dini rentan terhadap permasalahan keluarga karena dalam proses penyesuaian apabila tidak teratasi dapat berujung pada perceraian (Uecker, 2022).

(3) Aspek pendidikan

Dalam aspek pendidikan karena kurangnya pendidikan, perempuan yang sudah menikah tidak diberdayakan secara sosial dan ekonomi, mereka kurang memiliki kekuasaan dalam pengambilan keputusan, bahkan kehilangan kemampuan untuk bernegosiasi dengan mitra dan keluarga selama perilaku sehat. Akibat kurangnya pendidikan berarti wanita yang sudah menikah tidak akan dapat tawar- menawar dalam hal-hal yang mempengaruhi hidupnya dan keluarga karena kurangnya pemberdayaan (Birech, 2023).

(4) Kesehatan reproduksi

Logn, 1992 (dalam Priyanti, 2023) usia kawin pertama menjadi penanda awal mula

permasalahan kesehatan reproduksi. Menikah di usia dini memiliki resiko terkena kanker leher rahim rahim. Resiko terkena lesi prakanker leher rahim semakin tinggi pada wanita yang melakukan hubungan seksual lebih dini. Resiko untuk terkena kanker leher rahim semakin besar disebabkan pada usia tersebut terjadi perubahan lokasi sambungan skuamo-kolumner sehingga relatif lebih peka terhadap stimulasi onkogen.

Menurut Desiyanti (2022) permasalahan pernikahan dini di Indonesia perlu mendapatkan prioritas yang utama. Hal ini memiliki korelasi yang erat dengan laju pertumbuhan penduduk dan masa depan generasi dini bangsa. Program “Generasi Reproduksi” (GENRE) yang dicanangkan oleh BKKBN dirasa perlu lebih digencarkan lagi agar tersebar sampai ke pelosok desa.

C. Perilaku Seksual Pranikah

Perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis.

1. Bentuk perilaku seksual pranikah

Menurut Sarwono mengatakan bahwa perilaku seksual bermula dari perasaan tertarik hingga muncul tingkah laku berkencan, bercumbu serta bersenggama. Terutama pada Jenis kelamin dalam perilaku seksual, terdapat perbedaan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan perbedaan ini disebabkan oleh faktor

biologis dan social. Remaja laki-laki lebih mudah terangsang dan mengalami orgasme dibandingkan perempuan dan biasanya objek dari perilaku seksual tersebut berupa orang lain, orang dalam serta pada diri sendiri .

- a. Perasaan tertarik dalam minat dan keinginan remaja untuk bisa melakukan perilaku seksual seperti perasaan suka terhadap lawan jenis, perasaan sayang dan perasaan cinta
- b. Berkencan yaitu sebuah aktivitas remaja pada saat berpacaran yang berupa menemui atau bermain kerumah pacar.
- c. Bercumbu yaitu aktivitas remaja pada saat berpacaran yang dilakukan remaja berupa berpegangan tangan, mencium pipi/bibir, meraba payudara/alat kelamin.
- d. Bersenggama yaitu kesediaan remaja untuk melakukan hubungan seksual dengan pacarnya atau lawan jenis.

2. Klasifikasi Perilaku seksual

- a. Perilaku seksual beresiko Ringan
 - 1) Berkencan yaitu sebuah aktivitas remaja pada saat berpacaran yang berupa menemui atau bermain kerumah pacar.
 - 2) Menonton film yaitu sebuah aktifitas pada remaja pada saat berpacaran dengan menonton film yang disukai
 - 3) Jalan-jalan yaitu sebuah aktifitas pada remaja pada saat sedang berpacaran yang biasanya mereka jalan- jalan pada hari libur.
- b. Perilaku seksual beresiko sedang
Menurut (Crooks & Baur, 2022) Crooks dan Baur (2022) perilaku seksual remaja meliputi:

- 1) Masturbasi Ekspresi seksual noncoital seks adalah perilaku untuk merangsang organ kelamin dengan tujuan untuk mendapatkan kepuasan seksual, bagi laki-laki masturbasi adalah merangsang penis dengan menggosok-gosokan alat kelamin menggunakan tangan ataupun barang, pada masturbasi membuktikan di berbagai negara bahwa hampir setiap remaja laki-laki melakukan masturbasi dan melakukannya menjelang usia 17 tahun, dampak pada masturbasi ini menimbulkan infeksi pada alat kelamin, energi psikis dan fisik yang dimana remaja yang melakukan masturbasi menjadi orang mudah lelah, sulit berkomunikasi, malas melakukan aktifitas lain karena berfikir terus menerus kearah fantasi seksual. Sesuai dengan penelitian (Sari, 2023) perkembangan perilaku seksual pranikah remaja pada laki-laki lebih besar 66,7% responden dari pada dengan perempuan 53,2% responden. Pada remaja laki-laki kadar hormone testosteron meningkat membuat agerevitas libido pada remaja laki-laki berfantasi sebuah perilaku membayangkan atau imajinasi aktivitas yang bertujuan untuk menimbulkan erotisme dengan cara masturbasi.
- 2) Bersentuhan (touching) perilaku ini yang sering terjadi atau pada tahap ini secara umum dikatakan pantas terjadi di kencan pertama.
- 3) Berciuman (kissing) pada perilaku seksual yang terjadi ditahap ini berkisar dari ciuman singkat, ciuman sebentar-lama, sampai ciuman intim.

c. Perilaku seksual beresiko Berat

- 1) Bercumbu (petting) pada tahap ini biasanya terdiri dari sentuhan dan stimulasi terhadap area-area sensitive dari pasangan. Pada bercumbu ini biasanya meningkat dari cumbuan yang ringan hingga cumbuan didaerah genital
- 2) Hubungan seksual (sexual intercourse)/ Bersenggama sebuah aktifitas dengan memasukkan alat kelamin laki- laki ke alat kelamin perempuan, banyak remaja menganggap sekali melakukan hubungan seksual tidak akan menyebabkan kehamilan, padahal remaja yang melakukan bersenggama akan menimbulkan infeksi menular seksual, HIV dan AIDS serta kehamilan yang berisiko dikeluarkan dari sekolah, pernikahan dini, dan aborsi (Sari, 2023).

3. Dampak Perilaku Seksual Pranikah

Dari sebagian perilaku seksual memang tidak menimbulkan dampak apa-apa. Terutama jika tidak ada akibat fisik atau social yang ditimbulkan. Tetapi pada sebagian perilaku seksual yang lain berpeluang besar memungkinkan masuknya sperma kedalam vagina, perilaku seksual tersebut berdampak cukup serius Simkins,1984 dalam (Hafida Oktavia, 2022)

Dampak negative perilaku seksual pranikah yang dapat ditimbulkan pada remaja, diantaranya sebagai berikut:

- a. Dampak psikologis meliputi perasaan bersalah, rendah diri, depresi, marah, takut, dan berdosa.
- b. Dampak fisik meliputi dapat menyebabkan kehamilan tidak diinginkan (KTD) sampai tindakan aborsi, tertular penyakit menular seksual (PMS) seperti *syphiliss*, *herpes*, *ghonorhoe* hingga HIV/AIDS.

- c. Dampak sosial yang timbul seperti dikucilkan di lingkungan sekitar, putus sekolah karena menanggung aib dan merasa malu, perubahan peran menjadi ibu dan belum memiliki kesiapan untuk beralih peran menjadi ibu, timbulnya tekanan dari masyarakat yang mencela.

D. Remaja

1. Pengertian Remaja

World Health Organization (WHO) mendefinisikan remaja sebagai periode pertumbuhan dan perkembangan manusia yang terjadi setelah masa anak atau sebelum dewasa, dimulai dari usia 10 tahun sampai 19 tahun. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 tahun 2023, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun, sedangkan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yaitu usia remaja dimulai pada 10-19 tahun sampai 24 tahun dan belum menikah.

Menurut Hurlock (2022) masa remaja yaitu memiliki rentang kehidupan yang membedakan dengan periode sebelumnya dan sesudahnya, ciri-ciri masa remaja yaitu:

- a. Masa remaja sebagai periode perubahan diri
Suatu tingkat perubahan tingkah laku selama remaja yang sejajar dengan tingkat perubahan fisik yang dimana terdapat lima perubahan yang bersifat universal:
 - 1) Perubahan emosi yang intensitasnya bergantung pada tingkat perubahan fisik dan psikologis yang terjadi
 - 2) Perubahan tubuh

- 3) Perubahan minat dan peran dalam pergaulan social
 - 4) Perubahan nilai-nilai yang dianutnya dimana masa remaja biasanya menginginkan suatu perubahan, tetapi secara mental belum ada kesadaran tanggung jawab terhadap keinginan sendiri.
- b. Masa remaja sebagai masa mencari identitas diri
Pada tahun-tahun awal masa remaja, penyesuaian diri dengan kelompok masih tetap penting bagi remaja laki-laki dan perempuan. Salah satu cara untuk menampilkan identitas diri agar diakui oleh teman sebayanya atau lingkungan pergaulan, biasanya menggunakan simbol status dalam bentuk kemewahan atau kebanggaan lainnya yang bisa membuat dirinya diperhatikan atau tampil berbeda.
 - c. Masa remaja sebagai masa menimbulkan ketakutan
Pada masa ini, banyak anggapan yang bersifat negatif pada remaja, yaitu remaja sulit diatur dan cenderung berperilaku yang kurang baik. Hal tersebut yang membawa kekhawatiran dan ketakutan para orang tua sehingga dapat menimbulkan banyak pertentangan antara orang tua dengan anak remajanya yang mana dapat mengakibatkan terdapat jarak.
 - d. Masa remaja sebagai masa yang tidak realistis
Remaja cenderung untuk bisa melihat dirinya dan sebagaimana orang lain yang diinginkan, bukan sebagaimana adanya, terlebih dalam hal cita-cita. Semakin tidak realistis cita-citanya maka remaja akan menjadi semakin marah. Remaja akan sakit hati dan kecewa apabila orang lain membuatnya kecewa atau jika remaja tidak mencapai tujuan tersebut.

- e. Masa remaja sebagai lambing masa dewasa
Pada masa ini, remaja akan mengalami gelisah serta kesulitan untuk meninggalkan kebiasaan pada usia sebelumnya. Sementara usianya yang menjelang dewasa menuntut untuk meninggalkan kebiasaan yang melekat di usia sebelumnya tersebut. Remaja pada akhirnya memusatkan diri pada perilaku yang dihubungkan dengan status dewasa, yaitu merokok, minum-minuman beralkohol, mengkonsumsi obat-obatan terlarang, dan terlibat dalam perilaku seksual.

2. Perkembangan Remaja

Perkembangan remaja adalah sekumpulan proses yang memberikan perubahan dalam diri remaja dan terintergrasi sehingga timbul respons terhadap stimulus yang berasal dari luar tubuhnya. Dala proses penyesuaian diri enuju kedewasaan, ada 3 tahap perkembangan remaja (Sarwono, 2020).

- a. Remaja awal (*early adolescent*) usia 12-15 tahun
Pada tahap ini remaja masih heran dengan perubahan yang terjadi pada tubuhnya dan dorongan yang menyertai perubahan-perubahan itu. Mereka mengembangkan pikiran- pikiran baru, cepat tertarik pada lawan jenis, dan mudah terangsang secara erotis. Sulit mengerti dan dimengerti orang dewasa karena memiliki kepekaan yang berlebihan ditambah dengan berkurangnya kendali terhadap ego.
- b. Remaja madya (*middle adolescent*) usia 15-18 tahun
Tahap ini remaja sangat membutuhkan teman. Ia senang kalau banyak teman yang menyukainya. Ada kecenderungan narsistic yaitu mencintai diri sendiri, dengan menyukai teman- teman yang punya sifat yang sama dengan dirinya. Selain itu, ia berada dalam

kondisi kebingungan karena tidak tahu memilih antara peduli atau tidak peduli, ramai-ramai atau sendiri, optimistis atau pesimistis, idealis atau materialis, dan sebagainya. Remaja mencari identitas diri, timbul keinginan untuk kencan dan mengembangkan kemampuan berfikir abstrak.

c. Remaja akhir (*late adolescent*) usia 18- 21 tahun

Tahap ini adalah masa konsolidasi menuju periode dewasa dan ditandai dengan pencapaian lima hal, yaitu minat yang makin mantap terhadap fungsi-fungsi intelek egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang lain dan dalam pengalaman-pengalaman baru; terbentuk identitas seksual yang tidak akan berubah lagi; egosentrisme (terlalu memusatkan perhatian pada diri sendiri) diganti dengan keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dengan orang lain; dan tumbuh "dinding" yang memisahkan diri pribadinya (*private self*) dan masyarakat umum (*the public*). Menurut Gunarsa 2009 dalam (Hafida Oktavia, 2022) ada dua faktor yang memengaruhi perkembangan remaja, yakni faktor endogen (*internal*) dan eksogen (*eksternal*).

- 1) Faktor endogen merupakan faktor yang ada dalam diri sendiri baik secara fisik maupun psikis. Perkembangan ini berasal dari gen (keturunan) orang tuanya. Jika perkembangan remaja normal maka individu tersebut berasal dari keturunan yang normal, begitu pun faktor psikis dan psikososialnya. Faktor endogen yang normal menjadi dasar kuat remaja dalam melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya.

- 2) Faktor eksogen merupakan faktor yang berasal dari luar dirinya, meliputi faktor lingkungan, baik fisik maupun sosial. Lingkungan berupa letak geografis, musim, iklim, fasilitas, dan sebagainya. Faktor lingkungan sosial berupa: keluarga, teman sebaya, tetangga, sekolahan dan lain-lain.

BAB 4

PENDIDIKAN SEKSUAL KOMPREHENSIF SEBAGAI UPAYA PERNIKAHAN USIA DINI DAN KEKERASAN PADA ANAK & PEREMPUAN

A. Pendidikan Seksual Komprehensif

Comprehensive Seksual Education (CSE) adalah pendidikan berbasis kurikulum yang bertujuan untuk membekali anak dan remaja dengan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang memungkinkan mereka mengembangkan pandangan positif tentang seksualitas, dalam konteks perkembangan emosional dan sosial mereka (UNPFA, 2022). Comprehensive Seksual Education (CSE) adalah pembelajaran yang diajarkan kepada remaja sesuai dengan kelompok-kelompok usia serta diberikan secara konsisten, dengan melibatkan kemampuan dan pengalaman-pengalaman khas remaja. Model pembelajaran dalam pendidikan seksualitas dan sejenisnya pada dasarnya mengimplementasikan berbagai model pembelajaran. Namun demikian model pembelajaran CSE cukup memberikan pengaruh secara strategis. Pemberian informasi yang banyak dan detail menjadi ciri khas dari model pembelajaran CSE. CSE memberikan informasi dari mulai konsep diri terkait seksualitas, anatomi, fisiologi seksual, reproduksi, kehamilan, persalinan; infeksi menular seksual dan HIV / AIDS; kehidupan keluarga dan hubungan interpersonal;

budaya dan seksualitas; pemberdayaan hak asasi manusia, non-diskriminasi, kesetaraan dan peran gender; perilaku seksual dan keragaman seksual; dan pelecehan seksual, kekerasan berbasis gender dan praktik berbahaya (SIECUS, 2022; UNPFA, 2022). Materi mendetail yang diberikan dalam program ini pada dasarnya bersifat sebagai acuan dalam menyusun kurikulum di berbagai negara. Setiap negara akan mengimplementasikan dalam berbagai program yang sesuai dengan kebutuhannya. CSE terkadang dinamakan juga dengan “life skills program”, “family life”, HIV Education, “Hollistic Sexuality Education” tergantung pada fokus program yang dijalankan. Namun UNPFA mengingatkan bahwa prinsip-prinsip inti yang diidentifikasi dari internasional berbagai tentang laporan “pendidikan konsultasi seksualitas komprehensif harus meliputi hal berikut yaitu: Memajukan Hak Asasi Manusia, kesetaraan gender dan peningkatan kesehatan seksual dan reproduksi” (Bogota, 2022). Pendidikan seksual komprehensif berbeda dengan pendidikan seks karena komponennya yang lebih dari sekedar memberikan informasi organ reproduksi. Menurut International planned Association (IPPF) terdapat tujuh komponen pendidikan seksualitas komprehensif yaitu:

1. Gender

Mencakup; perbedaan gender dan seks, peran dan atribut gender, persepsi maskulinitas serta feminitas dalam keluarga dan perkembangan dalam hidup, perubahan norma dan nilai dalam masyarakat, manifestasi dan konsekuensi dari bias gender, stereotip dan stigmatisasi diri)

- a. Kesehatan reproduksi dan HIV Mencakup: seksualitas dan siklus kehidupan (pubertas, menopause, stigma,

problem seksual), anatomi, proses reproduksi, cara memakai kondom, bentuk-bentuk kontrasepsi lainnya (termasuk kontrasepsi darurat), pilihan dan informasi kehamilan, aborsi legal dan aman, aborsi tidak aman, pemahaman infeksi menular seksual (IMS) dan HIV, termasuk transmisi dan gejalanya, pencegahan HIV dan IMS, pencegahan transmisi virus dari ibu ke anak, suntik dan HIV, keperawanan, berpantang dan kesetiaan, respon seksual, ekspektasi sosial, kepercayaan diri dan keberdayaan, penghormatan terhadap tubuh, mitos serta stereotip.

- b. Hak seksual dan Hak Asasi Manusia Mencakup: pengetahuan tentang hak asasi manusia dan kebijakan nasional, hukum yang berkaitan dengan seksualitas, pendekatan hak dalam Kesehatan seksual dan reproduksi, Batasan sosial, budaya, dan etik dalam hak Kesehatan seksual dan reproduksi, batasan sosial, budaya, dan etik dalam hak kesehatan seksual dan reproduksi, pemahaman bahwa seksualitas dan budaya merupakan hal yang beragam dan dinamis, layanan yang tersedia dan cara mengaksesnya, partisipasi, praktik dan norma, keragaman identitas seksual, advokasi, pilihan, proteksi, kemampuan negosiasi, persetujuan dan hak untuk hanya berhubungan seksual Ketika siap, hak untuk mengekspresikan seksualitas secara aman dan sehat.

2. Kepuasan

Mencakup: bersifat positif terhadap seksualitas seseorang, pemahaman bahwa seks seharusnya menyenangkan dan tidak terpaksa, bahwa seks itu lebih dari sekedar hubungan seksual, seksualitas merupakan

bagian dari setiap orang, biologi dan perasaan di balik respon seksual manusia, gender dan kepuasan, kesejahteraan seksual, praktik seksual yang aman dan kepuasan, pengalaman seksual pertama, persetujuan, alkohol dan obat-obatan beserta dampaknya, pembahasan stigma yang kuat dengan kepuasan.

3. Kekerasan

Mencakup: kekerasan yang terjadi terhadap laki-laki dan perempuan serta bagaimana terjadinya (kekerasan berbasis gender), hubungan seksual non-konsensual dan pemahaman bahwa hubungan non-konsensual tidak dapat diterima, hak dan kebijakan, layanan yang tersedia dan pencarian bantuan, norma dalam masyarakat (kekuasaan, gender) dan mitos, pencegahan (termasuk keamanan personal), teknik bela diri, memahami dinamika korban dan pelaku, mekanisme penanganan korban, mencegah korban berubah menjadi pelaku, laki-laki dapat mencegah pelaku sekaligus kawan dalam pencegahan kekerasan.

4. Keragaman

Mencakup: mengenal serta memahami luasya keragaman dalam hidup (kepercayaan, budaya, etnisitas, status sosio-ekonomi, disabilitas, status HIV, dan seksualitas), sikap positif dalam melihat keragaman, mengenal diskriminasi, dampak negative, dan cara menghadapinya, mengembangkan nilai kesetaraan, dukungan terhadap remaja serta pemuda untuk meresapi nilai-nilai lebih dari sekedar toleransi.

5. Hubungan manusia

Mencakup: jenis-jenis hubungan manusia (keluarga, teman, seksual, romantis, dan lainnya), bahwa hubungan manusia dapat berubah dari waktu ke waktu,

perasaan serta kedekatan (fisik dan emosional), hak dan kewajiban, dinamika kuasa, hubungan yang sehat dan yang tidak sehat, komunikasi, percaya dan kejujuran dalam hubungan, tekanan sosial dan norma, rasa sayang dan seks tidak selalu sama. Komponen-komponen inilah yang menjadi elemen penting terhadap manifestasi pendidikan seksualitas komprehensif yang mana lebih dari sekedar tubuh dan organ reproduksi. Pendidikan seksual komprehensif adalah pencegahan penularan virus melalui pendekatan pendidikan.

Berdasarkan hasil penelitian Rima (2020), didapatkan terjadi peningkatan pengetahuan remaja tentang delapan topik seksualitas yaitu aktivitas seksual, anatomi dan fungsi organ reproduksi sendiri, anatomi dan fungsi organ reproduksi lawan jenis, IMS/HIV, kehamilan, aborsi, menggunakan media sosial dan kekerasan dalam pacarana setelah diberikan sosialisasi pendidikan seksual komprehensif.

Hasil riset penelitian Chi dan Xinli (2015) merumuskan bahwa ada pengaruh yang signifikan terhadap program pendidikan seks komprehensif terhadap pengetahuan kesehatan seksual dan sikap seksual, yang termasuk kesehatan seksual yaitu kesehatan reproduksi, kontrasepsi, penggunaan kondom, dan HIV/AIDS dan adanya perilaku positif sehabis diberikan edukasi.

Hasil riset penelitian Merry Fridha (2020) menyimpulkan bahwa comprehensive sexuality education sebagai pencegahan terhadap kekerasan seksual pada siswa-siswi SMP 8 Surabaya yang dibuktikan dengan siswa memiliki perbedaan pengetahuan sebelum dan setelah diberikan materi terkait pendidikan seksual. Hal ini menunjukkan bahwa siswa mulai memahami hal apa saja

yang sebaiknya dapat ia lakukan sehingga dapat terhindar dari kekerasan seksual, termasuk resiko yang akan diterima ketika mereka melakukan hubungan seksual.

Alligood 2022, mengatakan bahwa pendidikan kesehatan atau health promotion telah lama menjadi sandart bagi praktek keperawatan professional, yang di latar belakang oleh suatu bentuk pergeseran paradigma, dimana pergeseran paradigm aini terjadi dalam suatu bentuk pemberian pelayanan kesehatan yang menitik beratkan pada paradigma kesehatan yang lebih holistic dalam memandang suatu penyakit dari berbagai gejala penyebabnya, bukan sebagai fokus pelayanan kesehatan saja. Sesuai dengan model konseptual Nolla J Pender yang menyatakan bahwa terdapat perubahan paradigma tersebut sehingga menjadikan perawat selaku posisi kunci terhadap berbagai macam peran serta fungsinya dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, karena hampir di seluruh lapisan di bidang pelayanan kesehatan dalam melaksanakan pelayanan promosi serta preventif kesehatan yang dilaksanakan oleh perawat. Peran perawat adalah meningkatkan pemahaman masyarakat baik dalam keadaan sehat maupun sakit untuk meningkatkan derajat Kesehatan. Setiap manusia mempunyai karakteristik yang unik dan pengalaman yang dulu lebih fleksibel dijadikan variabel karena lebih relevan terhadap perilaku kesehatan utama populasi/kelompok utama.

1. Perilaku sebelumnya ataupun sasaran Perilaku dahulu memiliki pengaruh langsung serta tidak langsung terhadap perilaku promosi kesehatan yang akan dipilih, Adapun pengaruh tidak langsung yaitu melalui persepsi, manfaat, hambatan dan pengaruh aktivitas yang muncul dari perilaku tersebut.

2. Faktor Personal Factor personal terdiri dari; Biologi meliputi usia, jenis kelamin, indeks masa tubuh, status pubertas, status menopause, kekuatan, kekuatan dan keseimbangan. Psikologi mencakup harga diri, motivasi diri, kompetensi diri, serta persepsi status kesehatan dan definisi kesehatan. Sosial budaya mencakup ras, etnis, akulturasi pendidikan serta status sosial ekonomi.
3. Manfaat Tindakan
Manfaat Tindakan secara langsung memotivasi perilaku serta secara tidak langsung menjadi factor penentu rencana kegiatan untuk mencapai manfaat sebagai hasil. Manfaat ini menjadi reinforcement positif pada perilaku selanjutnya.
4. Hambatan yang dirasakan Ketidakmauan, ketidakcukupan, mahal, sukar atau tidak adanya waktu untuk melakukan kegiatan promosi. Rintangan yaitu sikap yang langsung menghalangi kegiatan melalui komitmen rencana kegiatan.
5. Keyakinan diri
Keyakinan diri yang dipersepsikan adalah pertimbangan atas kemampuan diri untuk mengorganisir dan melakukan suatu perilaku yang mempromosikan kesehatan. Keyakinan diri yang dirasa memengaruhi halangan yang dirasa bagi tindakan, sehingga semakin tinggi tingkat keyakinan maka semakin rendah tingkat halangan yang dirasa terhadap pengerjaan suatu perilaku.
6. Sikap yang berhubungan dengan aktivitas Emosi yang muncul pada kegiatan, tindakan diri, lingkungan di mana kegiatan tersebut berlangsung, pengaruh terhadap perilaku mengarahkan suatu reaksi emosional langsung dapat positif maupun negative,

menyenangkan atau tidak menyenangkan, perilaku yang memberi pengaruh positif sering diulang, sedangkan perilaku yang mempunyai pengaruh negatif dibatasi.

7. Pengaruh interpersonal, norma, dukungan dan model
Pengaruh interpersonal yaitu pengetahuan tentang perilaku, kepercayaan ataupun sikap orang lain. Kesadaran ini biasa maupun tidak biasa sesuai dengan kenyataan. Sumber utama pengaruh interpersonal yaitu keluarga, kelompok serta pemberi pengaruh pelayanan kesehatan. Pengaruh interpersonal terdiri dari norma (harapan orang lain), dukungan sosial instrumental dan dorongan emosional) dan model (belajar dari pengalaman orang lain).

8. Pengaruh situasional

Merupakan persepsi individu dan kognisi dari situasi yang dapat memfasilitasi maupun menghalangi perilaku misalnya pilihan yang tersedia, karakteristik kebutuhan serta ciri-ciri lingkungan estetik seperti situasi/lingkungan yang cocok, aman, tentram dari pada yang tidak aman serta terancam. Pengaruh situasional mampu menjadi kunci dalam pengembangan strategi efektif yang baru untuk memfasilitasi serta mempertahankan perilaku promosi kesehatan dalam populasi.

9. Komitmen terhadap rencana Tindakan Komitmen ini mendeskripsikan konsep tentang intensi serta identifikasi strategi yang terencana yang mendukung implementasi perilaku sehat.

10. Kebutuhan untuk berkompetisi

Kebutuhan mendesak yaitu perilaku alternatif buat individu dengan control diri rendah, sebab ada

ancaman lingkungan seperti tanggung jawab dan perawatan keluarga.

11. Hasil perilaku

Perilaku promosi kesehatan merupakan akhir atau hasil akhir Tindakan, perilaku ini akhirnya secara langsung ditujukan pada pencapaian hasil.

BAB 5

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pernikahan dini merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan (Luthfiyah, 2008:56). Pola pikir zaman primitif dengan zaman yang sudah berkembang jelas berbeda, hal ini dibuktikan dengan sebuah paradoks perkawinan antara pilihan orang tua dengan kemauan sendiri, pernikahan dini dipaksakan atau pernikahan dini karena kecelakaan.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di bawah umur yang telah ditetapkan dalam pernikahan usia sehat menurut BKKBN, yaitu perempuan yang menikah pertama kali pada umur di bawah 20 tahun dan laki-laki di bawah umur 25 tahun pada pernikahan pertamanya. Penetapan ini berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Berdasarkan kesehatan reproduksi, kehamilan di bawah umur 20 tahun bagi perempuan akan banyak risikonya karena kondisi rahim dan panggul belum berkembang optimal.

Pernikahan dini terjadi karena keinginan sendiri dari individunya, karena faktor budaya yang sudah ada semenjak dahulunya dan adanya nilai-nilai dalam masyarakat dalam menentukan umur yang layak untuk menikah. Ada nilai-nilai dalam masyarakat yang menganggap bahwa jika perempuan yang sudah berumur lebih dari dua puluh (20) tahun tetapi belum menikah, dianggap *gadiah gadang* atau gadis dewasa yang tidak laku

dan akan diberi gelar oleh teman-temannya yaitu "*ubi talampau kondiak*". Pernikahan dini berkaitan dengan banyaknya remaja yang putus sekolah dan pendidikan yang rendah, akibatnya perekonomian semakin terpuruk karena keahlian belum ada. Kebanyakan dari informan penelitian adalah mereka yang tidak tamat sekolah dasar (SD), karena pendidikan yang rendah sehingga dalam mendidik anak tidak dengan pola asuh yang benar dan akhirnya anak juga melakukan pernikahan dini.

Masa remaja merupakan tahap perkembangan psikologis yang potensial dan rentan, dikenal dengan fase mencari jati diri, karena difase ini mereka sudah tidak bisa dikatakan anak-anak namun juga belum bisa dikatakan sebagai golongan orang yang sudah dewasa, dan juga pada fase ini remaja belum mampu menguasai dan memfungsikan secara maksimal fungsi fisik maupun psikisnya.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai masalah global, sudah mencemaskan Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, menyandang predikat buruk dalam masalah pelanggaran HAM, yang salah satu diantaranya pelanggaran HAM perempuan dan anak. Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terjadi di mana saja (di tempat umum, di tempat kerja, di lingkungan keluarga (rumah tangga) dan lain-lainnya. Dapat dilakukan oleh siapa saja (orang tua, saudara laki-laki ataupun perempuan dan lain-lainnya dan dapat terjadi kapan saja (siang dan malam).

Selanjutnya yaitu karena motif ekonomi yang ingin mengurangi beban orang tua, agar kebutuhan sehari-hari menjadi tanggung jawab suami. Maka ketika sudah ada yang melamar mau-mau saja menikah dini, tapi pada

kenyataannya malah menambah beban orang tua karena belum memiliki pekerjaan.

Selain itu juga ada pengaruh dari teman sebaya (peer group), kebanyakan pernikahan dini yang terjadi juga karena pengaruh lingkungan yang melihat teman-teman menikah sehingga juga punya keinginan untuk segera menikah. Mereka hanya memikirkan senang kalau sudah menikah karena melihat temantemannya yang sudah menikah dan takut juga kalau harus kehilangan pasangannya jika tidak segera menikah.

Pernikahan dini tidak hanya mendatangkan dampak negatif tetapi juga positifnya, seperti agar terhindar dari pergaulan bebas karena dulu pernah ada kasus hamil diuar nikah dan dari segi ekonomi pernikahan dini juga menguntungkan. Karena disaat sudah memiliki anak, maka disaat anak-anak membutuhkan biaya orang tua masih kuat mencari nafkah.

Sementara itu, Ariyandini (2022) mengatakan perilaku seksual pranikah adalah perilaku yang didorong oleh hasrat seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan mulai dari berkencan, bercumbu, sampai besenggama tanpa adanya ikatan pernikahan yang resmi berdasarkan agama dan hukum. Berdasarkan berbagai konsep di atas, maka perilaku seksual pranikah dapat diartikan sebagai tingkah laku yang berhubungan dengan dorongan seksual dengan lawan jenis maupun sesama jenis yang dilakukan sebelum adanya ikatan pernikahan yang sah baik secara hukum maupun agama.

B. Saran

Banyaknya kejadian pernikahan dini seharusnya ibu atau orang tua menjadi *role model* bagi anak dan melindungi anak dari praktik pernikahan dini serta memberikan nasehat dan gambaran bagaimana kehidupan berumah tangga yang harus dihadapi nantinya agar tidak mengalami apa yang mereka alami. Sebagai generasi penerus bangsa sebaiknya anak muda harus semangat untuk belajar dan menempuh jenjang pendidikan setinggi-tingginya. Menghindari pengaruh buruk lingkungan agar terhindar dari praktik pernikahan dini dan memikirkan serta mempersiapkan secara matang sebelum melakukan pernikahan agar nantinya tidak terjadi penyesalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, F. (2022) Pernikahan Dini, Nikah Siri dan Perceraian (Studi Kasus Pada Masyarakat Minang di Jorong Mawar, Nagari Lubuak Jantan, Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat). Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Available at: <http://repository.usu.ac.id>.
- Arimurti Intan (2022) "Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso," *The Indonesian Journal Of Public Health*, 12(2), pp. 249–2
- Appulembang, Y. A., Fajar, N. A., Hosana, A., & Tarigan, Z. (2019). *Peran Keluarga dalam Upaya Pencegahan Perilaku Seks Pranikah Remaja di Palembang The Role of Family in Prevention Adolescent Premarital Sexual Behavior in Palembang*. 11(2), 151–158.
- Arista, D. (2022). Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Seksual Berisiko di Kalangan Remaja SMA Negeri 1 Kota Jambi Tahun 2015. *Scientia Journal*, 4(3), 255–264.
- Angelina, D., Barus, B., Isabela, M., Harut, S. I., Oeleu, D., Yunince, M. S., Keron, M. K., Haridyani, M. H., Angelina, D., Barus, B., Isabela, M., Harut, S. I., Yunince, M. S., & Haridyani, M. H. (2023). Pelatihan self-control mengatasi dorongan seksual dalam hidup membiara. 3(1), 62–67.
- Ariska, A., & Yuliana, N. (2021). Hubungan tingkat pengetahuan remaja tentang kesehatan

reproduksi dengan sikap terhadap perilaku seksual pranikah di smpn 2 jatipuro. Jurnal Stethoscope, 1(2),138–144.

<https://doi.org/10.54877/stethoscope.v1i2.814>

Asmin, E., Saija, A. F., & Titaley, C. R. (2023). Analisis perilaku seksual remaja laki-laki dan perempuan di kota ambon. *Molucca Medica*, 16(1),11–18. <https://doi.org/10.30598/molmed.2023.v16.i1.11>

Averill, J. R. (22). Personal control over aversive stimuli and its relationship to stress. *Psychological Bulletin*, 80(4), 286–303. <https://doi.org/10.1037/h0034845>

Ayu, G., Dantes, N., & Jampel, I. N. (2022). Pengaruh penerapan model coreterhadap kecamatan denpasar barat. *E-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha*, 5(1), 1–10. <http://download.portalgaruda.org/>

Azwar, S. (2022). Metode penelitian. Pustaka Pelajar. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2022). Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-hal Reproduksi bagi Remaja Indonesia. BKKBN. https://digilib.bkkbn.go.id/index.php?p=show_detail&id=11270

Alfiyah. (2022). Sebab-sebab Pernikahan Dini. <http://alfiyah23.student.umm.ac.id>.

Afifuddin, H. & Saebani, B.H. 2022. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung:Pustaka Setia.

Aisyah, Nopalina Suyanti Damanik. "Faktor- faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Puteri Di Wilayah Kerja Puskesmas Ujung Kubu Kabupaten Batubara Tahun 2022." *Jurnal Ilmu*

Kedokteran dan Kesehatan Indonesia 2, No. 3
(November 2022): 41.

Abu Huraerah, 2022, Kekerasan Terhadap Anak, Bandung:
Nuansa.

Adawiyah, S., & Winarti, Y. (2021). Hubungan Usia dan Jenis Kelamin dengan Inisiasi Seks Pranikah Pada Remaja di SMK Istiqomah Muhammadiyah 4 Samarinda. *Borneo Student Research*, 2

Ahmad Kholid. (2022). *Promosi Kesehatan Dengan Pendekatan Teori Perilaku, Media, dan Aplikasi untuk Mahasiswa dan Praktisi Kesehatan*. (Rajawali Pers. (ed.)).

Anisa, R. (2022). *Intensi Orang Tua Dalam Pengambilan Keputusan Untuk Menikahkan Anak Perempuan Di Bawah Usia 20 Tahun Di Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso*. 58–65.

Arianti, W. desi. (2022). Persepsi Remaja tentang Pernikahan Dini di SMA Pesantren Guppi Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.*, 63.
[http://repositori.uin-](http://repositori.uin-alauddin.ac.id/12255/) alauddin.ac.id/12255/

Ardyanti, P. V., & Tobing, D. H. (2017). Hubungan Konsep Diri dengan Konformitas pada Remaja Laki-Laki yang Mengonsumsi Minuman Keras Adolescents in Nazarabad. *The International Journal of Indian Psychology*, Vol 3 No 1, 1-11. Gulati, S. (2022, June). Azwar, S. (2022). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

BKKBN. (2022). *Pernikahan Dini Pada Beberapa Provinsi di Indonesia: Akar Masalah dan Peran Kelembagaan*

Daerah 3rd ed. A. Yuswono, ed. Jakarta: Badan Kependudukan

Badan Koordinasi Keluarga, & (BKKBN), B. N. (2017). *USIA PERNIKAHAN IDEAL 21-25 TAHUN*. <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/b%0AKkbn-usia- pernikahan-ideal-21-25%0ATahun>

Badan Pusat Statistik. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. *Badan Pusat Statistik*, 6–10.

Badan Pusat Statistik Kab.Tangerang. (2021). *INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN TANGERANG* (Septian Reza Pradana (ed.)).

Baron, R., & Byrne, D. (2012). Psikologi Sosial. Jakarta: Erlangga.

Berk, L. (2022). Development Through The Lifespan. (Daryanto, Penyunt.) Yogyakarta Pustaka Pelajar.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional [BKKBN]. (2022). Pernikahan dini pada beberapa provinsi di Indonesia: dampak overpopulation, akar masalah dan peran kelembagaan di daerah.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). Pencegahan perkawinan anak: percepatan yang tidak bisa ditunda. [https://batukarinfo.com/system/files/](https://batukarinfo.com/system/files/PUSKAPA-Child-Marriage-) PUSKAPA-Child-Marriage-

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional [BKKBN]. (2022). Pernikahan dini pada beberapa provinsi di Indonesia: dampak overpopulation, akar masalah dan peran kelembagaan di daerah.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). Pencegahan perkawinan anak: percepatan yang tidak bisa ditunda.

<https://batukarinfo.com/system/files/> PUSKAPA-Child-Marriage-

- Carolyn, B. T., Lubis, R., Kebidanan, S., Kesehatan, F. I., & Jakarta, U. N. (2021). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini. *Jurnal Kebidanan*, 7(1), 17–24.
- Creswell, J. W. (2022). *Research Design*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dalima Padut, R., Nggarang, B. N., Eka, A. R., Sarjana Keperawatan FIKP Unika St Paulus Ruteng Jl Jend Ahmad Yani, P., & Flores, R. (2021). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Seksual Berisiko Pada Remaja Kelas Xii Di Man Manggarai Timur Tahun 2021. *Stikessantupaulus.E- Journal.Id*, 6(1), 2548–4702. <https://stikessantupaulus.e-journal.id/JWK/article/view/116>
- Desiyanti, I. W. (2022). Faktor-faktor yang berhubungan terhadap pernikahan dini pada pasangan usia subur di kecamatan Mapanget Kota Manado factors associated with early marriage in couples of childbearing age at Kecamatan Mapanget Manado City. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Unsrat*, 5(2), 270–280. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jikmu/article/view/7443/6987>
- Dameshghi, S., & Kalantarkousheh, S. M. (2022). The Relationship between Identity Crisis and Responsibility of Impact Of Peer Pressure On

[ps://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.127252](https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.127252)[0Ahttps://doi.org](https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.127252)

- Hermiina Humune, (2022). *Tingkat Pengetahuan Remaja Sma Tentang Pendidikan Seks Dan Sikap Remaja Sma Tentang Seks Bebas. Surabaya. Akademi Kebidanan Griya Husada.*
- Hammer, J., & Hartati, S. (2022). Hubungan Antara Konformitas Dengan Intensi Membeli Smartphone Pada Remaja Sma Karangturi Semarang Jurnal Empati, Vol 3 No 4 :1-10.
- Huriyati, & Hidayah, N. (2022). Krisis Identitas Pada Remaja, Vol 10 No 1, 49-62.
- Indriati, Susanti, Y., & PH, L. (2022, September). Hubungan Perilaku Terhadap Harga Diri Remaja Putus Sekolah Dalam Pembentukan Identitas Diri. Jurnal Keperawatan, Vol 8 No 2, 1-7.
- Ningsih, S. . (2021). Analisis Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda (Studi Kasus di Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan). Universitas Airlangga Reproduksi Dengan Perilaku Seks Pranikah Pada Remaja Usia (15-17 Tahun) Di SMK Yadika 13 Tambun Bekasi," Jurnal Ilmiah WIDYA, 53(9), pp.1923-1926.doi:10.1002/1097-0142(19840501)53:9<1923:AIDCNCR2820530919>3.0.CO;2-M.
- Nurmalisa, Y. (2022). Persepsi Orang Tua terhadap Pernikahan Dini di Kelurahan Garuntang. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta
- Purnamasari, S. E., & Wimbrata, S. (2022). Efektivitas pendidikan seksualitas terhadap peningkatan

kontrol diri pada remaja putri yang telah aktif secara seksual. Publikasi Tesis, 1 28.<https://fpsi.mercubuana-yogya.ac.id/wp-content/uploads/2022/06/publikasi-tesis-santi.pdf>

Putro, K. Z. (2022). Memahami Ciri dan Tugas Perkembangan Masa Remaja. *APLIKASIA: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, Vol. 17, No. 1, 1-8. Arak di Gianyar Bali. *Jurnal Psikologi Udayana*, Vol. 4, No.1, 30-40.

Rika Saraswati, 2022, Perempuan dan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga, Citra Aditya Bakti, Bandung;

Tri Panjiasih Susmiarsih, Dkk. (2022). *Peningkatan Pengetahuan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perilaku Seks dalam Upaya Cegah Seks Pranikah pada Siswa-Siswi SMPN 77 dan SMAN 77 Jakarta Pusat*. Jakarta: Universitas YARSI.

GLOSARIUM

A

Adolenseses/adolescent: periode kritis peralihan dari anak menjadi dewasa. Pada remaja terjadi perubahan hormonal, fisik, psikologis maupun sosial yang berlangsung secara sekuensial. Pada anak perempuan awitan pubertas terjadi pada usia 8 tahun sedangkan anak laki-laki terjadi pada usia 9 tahun.

B

Bersenggama : kesediaan remaja untuk melakukan hubungan hubungan seksual dengan pacarnya atau lawan jenis.

C

Comprehensive Seksual Education (CSE) : pendidikan berbasis kurikulum yang bertujuan untuk membekali anak dan remaja dengan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang memungkinkan mereka mengembangkan pandangan positif tentang seksualitas, dalam konteks perkembangan emosional dan sosial mereka

E

Eksplisit: penyampaian secara langsung, dimana isi dan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis dapat dipahami secara langsung.

H

HIV: human immunodeficiency virus merupakan virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4.

I

IMS (Infeksi Menular Seksual): gangguan yang ditularkan melalui hubungan seksual, disebabkan oleh bakteri, virus, atau parasit.

K

Komprehensif: luas, menyeluruh, teliti, dan meliputi banyak hal.

KTP (kekerasan Terhadap Perempuan) :

mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, psikis, atau seksual, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang.

L

Literasi: kemampuan untuk membaca, menulis, dan berbicara, serta mengolah informasi dan pengetahuan untuk kehidupan sehari-hari.

Literasi Kesehatan: kemampuan seseorang untuk mendapatkan, memahami, dan menggunakan informasi kesehatan untuk meningkatkan status kesehatan.

M

Morbiditas: angka kesakitan atau kondisi seseorang yang sakit dan tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari normalnya.

Mortalitas: angka kematian atau jumlah kematian yang terjadi pada suatu populasi atau wilayah.

N

Nekrosis: bentuk cedera sel yang mengakibatkan kematian prematur sel-sel pada jaringan hidup dengan autolisis.

Nikotin: zat kimia yang bersifat adiktif dan terdapat dalam berbagai tumbuhan, terutama tembakau.

P

Prevalensi: ukuran yang menunjukkan proporsi populasi yang memiliki karakteristik tertentu dalam periode waktu tertentu.

S

Stereotip : penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok dimana orang tersebut dapat dikategorikan.

T

Transient Ischaemic Attack (TIA): kondisi medis yang terjadi ketika suplai darah ke otak terganggu secara sementara.

Trombosis: kondisi ketika darah menggumpal di dalam pembuluh darah, yang dapat menghalangi aliran darah normal dan menyebabkan komplikasi serius.

PROFIL PENULIS



Sofa Qurrata A'yun merupakan anak perempuan nomor 8 dari 9 bersaudara, lahir di Sampit (Kalimantan Tengah) 26 juli 1989, dan Penulis berdomisili di Jl. Sidingkap RT/RW 01/02 kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Madura Provinsi Jawa Timur. Penulis menempuh pendidikan sekolah dasar di SD.Nepa kabupaten sampang dan lulus di tahun 2002,penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP 05 Bangkalan tahun 2005, dan melanjutkan pendidikan menengah atas di MAN MODEL bangkalan dan lulus di tahun 2008, penulis kembali menempuh pendidikan DIII kebidanan di STIKes husada mojokerto lulus pada tahun 2011, dan melanjutkan pendidikan DIV Kebidanan di STIKes Insan Unggul Surabaya lulus pada tahun 2012, penulis juga pernah bekerja di salah satu puskesmas di kabupaten sampang madura selama 3 tahun, dan kembali penulis melanjutkan pendidikan Strata II (S2) Di STIKes Guna Bangsa Yogyakarta lulus pada tahun 2018, Penulis adalah staf pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Jombang di Kabupaten Jombang. Di Program Studi S1 Kebidanan. dan penulis kembali melanjutkan pendidikan di program Studi Doktor (S3) Kesehatan Masyarakat Di Universitas STRADA Indonesia di Kabupaten Kediri. Penulis telah menerbitkan beberapa buku kesehatan seperti : Asuhan kebidanan pada anak dan perempuan dengan kondisi rentan, Asuhan kebidanan pada bayi baru lahir, Modul Praktik mahasiswi kebidanan.

PROFIL PENULIS



Dina Camelia, S.Kep.,Ns.,M.Tr.Kep lahir di Sampit (Kalimantan Tengah), dan Penulis berdomisili di Jl. Sidingkap RT/RW 01/02 kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Madura Provinsi Jawa Timur. Penulis adalah staf pengajar di Departemen Keperawatan Medikal Bedah Jurusan Keperawatan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bahrul Ulum Tambak Beras

Kabupaten Jombang. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 Keperawatan di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya tahun 2010-2014 lalu melanjutkan Pendidikan Ners di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya tahun 2014-2015 dan melanjutkan pendidikan S2 Keperawatan di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya tahun 2019-2021. Penulis telah menerbitkan beberapa buku kesehatan seperti: buku penyakit sistem pernafasan, buku penyakit sistem perkemihan, buku penyakit sistem pencernaan, dan buku asuhan keperawatan sistem pernapasan aplikasi SDKI,SIKI, SLKI.

SINOPSIS BUKU

Buku ini membahas tentang **Pendidikan Seksual Komprehensif sebagai salah satu upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini, dan Kekerasan Pada Anak dan Perempuan**

Pendidikan seksual merupakan pendidikan berbasis kurikulum yang bertujuan untuk membekali anak dan remaja dengan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang memungkinkan mereka mengembangkan pandangan positif tentang seksualitas, dalam konteks perkembangan emosional dan sosial mereka.

Dalam konteks pendidikan seksual komprehensif untuk mencegah pernikahan usia dini, sehingga buku ini menekankan bahwa keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pencegahan pernikahan dini dan kekerasan pada anak dan perempuan. Keluarga bukan hanya sebagai pendukung dalam perkawinan, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam mencegah terjadinya pernikahan dini dan kekerasan pada anak dan perempuan. Melalui peningkatan literasi kesehatan, keluarga dapat lebih sadar dan aktif dalam mengidentifikasi tanda-tanda peringatan dini pernikahan usia dini, dan menjalankan pola hidup yang mendukung pendidikan seksual komprehensif untuk pencegahan pernikahan usia dini, kekerasan pada anak dan perempuan

Buku ini tidak hanya menyasar individu sebagai pembaca, tetapi juga memberikan wawasan kepada para profesional kesehatan, masyarakat, dan organisasi terkait dalam upaya bersama untuk menurunkan angka kejadian pernikahan usia dini, kekerasan pada anak dan perempuan melalui peningkatan literasi kesehatan keluarga.

Buku ini membahas tentang Pendidikan Seksual Komprehensif sebagai salah satu upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini, dan Kekerasan Pada Anak dan Perempuan

Pendidikan seksual merupakan pendidikan berbasis kurikulum yang bertujuan untuk membekali anak dan remaja dengan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang memungkinkan mereka mengembangkan pandangan positif tentang seksualitas, dalam konteks perkembangan emosional dan sosial mereka.

Dalam konteks pependidikan seksual komprehensif untuk mencegah pernikahan usia dini, sehingga buku ini menekankan bahwa keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pencegahan pernikahan dini dan kekerasan pada anak dan perempuan. Keluarga bukan hanya sebagai pendukung dalam perkawinan, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam mencegah terjadinya pernikahan dini dan kekerasan pada anak dan perempuan. Melalui peningkatan literasi kesehatan, keluarga dapat lebih sadar dan aktif dalam, mengidentifikasi tanda-tanda peringatan dini pernikahan usia dini, dan menjalankan pola hidup yang mendukung pendidikan seksual komprehensif untuk pencegahan pernikahan usia dini, kekerasan pada anak dan perempuan

Buku ini tidak hanya menyasar individu sebagai pembaca, tetapi juga memberikan wawasan kepada para profesional kesehatan, masyarakat, dan organisasi terkait dalam upaya bersama untuk menurunkan angka kejadian pernikahan usia dini, kekerasan pada anak dan perempuan melalui peningkatan literasi kesehatan keluarga.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7139-11-5



9

786347

139115